QUESTÃO 1. A creatinina é uma substância usada para avaliar a função renal, assim como a ureia também pode ser usada. Sobre essas duas substâncias e a fisiologia delas no organismo. Assinale a correta: *

A. A dieta de um paciente com DRC deve ter pouca proteína devido, um dos motivos, diminuir a síntese de creatinina, mas não de uréia, visto que só a primeira deriva do metabolismo proteico.
B. A creatinina assim como a uréia são usadas com segurança na avaliação da função renal devido a capacidade de serem filtradas, secretadas, mas não reabsorvidas.
C. A creatinina isolada serve como parâmetro de alta especificidade e sensibilidade para averiguar a função renal.
D. O nível sanguíneo de creatinina é função proporcional da massa muscular, é inversamente proporcional à taxa de filtração renal.

QUESTÃO 2. Qual é a metástase hematogênica mais frequente do câncer de próstata?

A. Hepática.
B. Renal.
C. Pulmonar.
D. Óssea.

QUESTÃO 3. Na lesão renal aguda por necrose tubular aguda a concentração do sódio urinário está elevada por vários motivos, entre eles:

A. O sódio é perdido por perda da polaridade das células tubulares renais.
B. O sódio é mais secretado por ação da aldosterona.
C. Há uma maior ação do hormônio antidiurético reabsorvendo água.
D. Ocorre uma maior reabsorção de água por vazamento retrógrado.

QUESTÃO 4. Paciente de sexo masculino, 26 anos, com vida sexual ativa (várias parceiras nos último meses), apresentando adenomegalia inguinal/femoral direta, progressiva, com aparecimento de sinais flogísticos, drenando secreção purulenta, espontaneamente através de vários pontos e com sinal do sulco (separação dos nódulos linfáticos inflamados da região inguinal dos da femoral, permanecendo- os acima e abaixo do ligamento de Poupart), já apresentando dor e dificuldade para defecar, com fistulização retal. Nega ter tido lesões ulceradas no pênis (sic). Para confirmar a hipótese clínica mais correta para esta situação, dentre os exames abaixo, qual seria o mais indicado e confirmaria o diagnóstico ?

A. Pesquisa de bacilos Gram negativos através de Bacterioscopia pelo Gram da secreção drenada do bulbão ou Cultura para Haemophilus ducreyi
B. Bacterioscopia pelo Gram da secreção do bulbão, com ênfase a pesquisa de diplococos Gram negativos, intra e extra celulares.
C. Pesquisa de Clamidia na secreção do bulbão, através, por exemplo, de Imunofluorescência direta da secreção ou pesquisa por reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para Clamidia.
D. Pesquisa de corpúsculo de Donovan (em secreção corada pelo Leishman ou biópsia corada pelo Giemsa).

QUESTÃO 5. Uma mulher de 25 anos tem início súbito de febre, mal-estar e náusea. Exame da urina de rotina mostra proteína 1+, ausência de cetonas, ausência de glicose e sangue 4+, com cilindros hemáticos ao exame microscópico. Há acentuada hipercelularidade glomerular por microscopia óptica, com neutrófilos nas alças capilares glomerulares. A microscopia por imunofluorescência revela deposição granular de IgG e C3 nas membranas basais capilares glomerulares. À microscopia eletrônica, observam-se "gibas" subepiteliais eletrondensas. O diagnóstico mais provável é: *

A. Diabetes mellitus.

B. Síndrome de Goodpasture.
C. Glomerulonefrite pós-infecciosa.
D. Glomerulonefrite membranosa.

QUESTÃO 6. Sobre a Litotripsia Extra Corpórea (LECO), julgue as afirmativas abaixo e marque a correta. *

A. Poderá ser realizado mesmo na presença de obstrução e infecção.
B. A LECO deve ser indicada para cálculos calicinais sintomáticos ou maiores que 5 mm e menores que 20 mm.
C. Cálculos com densidade topografia acima de 1000UH tem melhor resultado com a LECO
D. Alterações na coagulação sanguínea não contraindicam o procedimento.

QUESTÃO 7. Os IECA e BRA são renoprotetores porque?

A. Aumentam a resistência da arteríola aferente
B. Aumentam a resistência da arteríola eferente
C. Aumentam o fluxo plasmático renal
D. Aumentam o calibre da arteríola eferente

QUESTÃO 8. Qual dos seguintes sintomas não é considerado de armazenamento (irritativo)?

A. Polaciúria.
B. Noctúria.
C. Sensação de esvaziamento incompleto.
D. Urgência miccional.

QUESTÃO 9. Criança de oito anos, após diagnóstico de impetigo há 15 dias, dá entrada no pronto-socorro com quadro de dispneia, cansaço, edema, hipertensão arterial, diminuição do volume urinário e coloração avermelhada na urina há 48 horas. A fisiopatologia envolvida no surgimento da hipertensão arterial e edema neste caso são:

A. Aumento da permeabilidade da membrana basal glomerular e hipovolemia.
B. Aumento da filtração glomerular com maior reabsorção tubular de água
C. Necrose tubular aguda secundária ao quadro infeccioso e oligúria.
D. Diminuição da filtração glomerular e hipervolemia

QUESTÃO 10. Em relação ao PSA (antígeno prostático específico) assinale a alternativa CORRETA:

A. A relação PSA total/ PSA livre acima de 20 por cento é sugestiva de malignidade.
B. O uso de inibidores de 5 redutase diminui em 10 por cento e valor do PSA após 1 ano de tratamento.
C. O aumento do PSA na HPB é de 0,8 ng/grama de tecido hiperplásico/ano, enquanto no Ca de próstata o aumento é 3 vezes maior.
D. O PSA se altera com infecção urinária.

QUESTÃO 11. Paciente com obesidade mórbida evolui com quadro clínico e laboratorial compatível com síndrome nefrótica e foi submetida à biópsia renal que mostrou alguns glomérulos alterados, com lesões segmentares de esclerose e colapso de alças capilares. Baseado neste laudo da biópsia renal pode-se dizer que se trata de: *

A. Glomerulosclerose segmentar e focal
B. Glomerulonefrite membranosa
C. Glomerulonefrite membranoproliferativa
D. Doença por lesões mínimas

QUESTÃO 12. Doença por lesões mínimas
Na Nefropatia Diabética (ND) é correto afirmar:

A. A biópsia renal está indicada quando houver indícios clínico-laboratoriais de que a nefropatia pode não ser diabética
B. Os níveis pressóricos para pacientes com nefropatia diabética clínica devem ser < 140/85 mmHg
C. A presença de microalbuminúria determina progressão inexorável da nefropatia diabética para doença renal crônica (DRC)

D. Espessamento da membrana basal glomerular e hipertrofia glomerular são achados tardios da nefropatia diabética

QUESTÃO 13. Sobre escroto agudo, assinale a correta: *

A. Ultrassonografia com doppler de testículo é exame que nada acrescenta na investigação de escroto agudo.
B. Em caso de abordagem cirúrgica em que se confirme torção testicular, a fixação do testículo contralateral é necessária.
C. Torção de cordão espermático (ou torção de testículo) é o diagnóstico a ser excluído no atendimento do paciente com dor testicular aguda.Sabe-se que quase a totalidade dos testículos é preservada quando a exploração cirúrgica é realizada em até 24 horas após o início do quadro.
D. Trauma contusos de testículo não pode ter indicação de tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 14. São exemplos de LRA pré-renal:

A. trombose de veia renal, infarto agudo do miocárdio e vômitos.
B. hiperplasia prostática benigna, infarto agudo do miocárdio e diarreia.
C. rabdomiólise, diarreia e vômitos.
D. insuficiência cardíaca, grande queimado e vômitos.

QUESTÃO 15. Qual a principal causa de Doença Renal Crônica dialítica no Brasil? *

A. Diabete melito
B. Urolitíase
C. Hipertensão arterial sistêmica
D. Doença renal policística

QUESTÃO 16. Assinale a alternativa CORRETA:

A. Hipernatremia importante é rara se o paciente tem o mecanismo da sede intacto e livre acesso à água.
B. Diabetes insípidus é uma causa comum de hiponatremia.
C. A correção intempestiva de uma hiponatremia crônica pode levar a edema cerebral.
D. A mielinólise pontina é a lesão neurológica causada pela correção rápida da hipernatremia.

QUESTÃO 17. Um homem saudável de 72 anos sente dificuldade crescente à micção. Ele precisa levantar várias vezes durante a noite em razão de sensação de urgência, mas a cada vez o volume de urina é pequeno. Ele tem dificuldade em inicial e interromper a micção. Este problema se agravou nos últimos anos. O nível sérico de PSA está levemente aumentado, mas estável durante esse período. Biopsia da próstata provavelmente revelará: *

A. Glândulas mal diferenciadas revestidas por uma única camada de epitélio, com fusão de ácinos.
B. Nódulos hiperplásicos de estroma e glândulas revestidas por duas camadas de epitélio.
C. Múltiplas áreas de inflamação granulomatosa caseosa.
D. Células inflamatórias com predomínio de neutrófilos e abscessos no estroma e em glândulas.

QUESTÃO 18. De acordo com os parâmetros seminais do manual da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2010, as alterações morfológicas, com base nos parâmetros de Kruger, com morfologia normal menor do que 4%, recebem o nome de: *

A. Hipospermia.
B. Teratozoospermia.
C. Criptozoospermia
D. Astenozoospermia.

QUESTÃO 19. Hipospádia é uma anomalia do sistema urogenital muito frequente. Sobre esta condição é correto: *

A. A grande maioria dos casos é proximal.
B. Hipospádias posteriores podem ter relação com infertilidade.
C. Existe apenas uma técnica cirúrgica descrita para tratamento de hipospadias.

D. Hipospadias penoescrotal, escrotal ou perineal são de correção mais simples do que apresentações distais.

QUESTÃO 20. Uma criança de 2 anos possui uma massa no testículo esquerdo com 2,5cm de diâmetro e bem circunscrita. Histologicamente, essa massa demonstra lâminas de células com glândulas mal definidas compostas de células cubóides, algumas das quais contendo glóbulos hialinos eosinofílicos. A análise encontra microcistos e estruturas glomeruloides primitivas. É demonstrada AFP (alfa fetoproteína) no citoplasma das células neoplásicas por imuno-histoquímica. A criança provavelmente tem: *

A. Tumor do saco vitelino.
B. Teratoma.
C. Coriocarcinoma.
D. Seminoma.

QUESTÃO 21. A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma das doenças mais prevalentes do idoso. Estima-se que cerca de 50% dos homens maiores de 80 anos apresentam essa condição. A respeito desse tema, assinale a alternativa incorreta.

A. O arsenal terapêutico medicamentoso envolve Alfa bloqueadores que relaxam a musculatura lisa da próstata inibidores da enzima 5-alfaredutase que bloqueiam a conversão de testosterona em di-hidrotestosterona.
B. Foram descritos efeitos apoptóticos induzidos por bloqueadores alfa-1 e finasterida. Porém, esses efeitos são descritos como secundários e não se tem certeza se eles efeitos são suficientes para o controle da HPB.
C. O tratamento farmacológico da HPB baseia-se na atuação dos fármacos sobre o componente mecânico desta patologia, com o uso de alfa-bloqueadores por diminuição do volume prostático e sobre componente dinâmico com o uso de inibidores da 5-alfaredutase.
D. Antagonistas para receptores alfa 1-A e alfa 1-D, como a alfuzonina, têm uma incidência de hipotensão postural menor, devido à sua maior seletividade sobre os subtipos de adrenoceptores.

QUESTÃO 22. Acerca da farmacoterapia para tratamento da disfunção erétil, assinale a opção correta.

A. Aos pacientes com ausência de ereção no TEFI (Teste de ereção fármaco induzida) independente da integridade do sistema de veno-oclusão, deve ser recomendado o tratamento intracavernoso intermitente (FIC).
B. Agentes vasodilatadores como a fentolamina e a papaverina constituem o tratamento de primeira linha principalmente para pacientes com disfunção erétil de origem mista.
C. O uso de drogas como etanol e de fármacos como determinadas classes de anti-hipertensivos e diuréticos estão associados com a Disfunção Erétil de origem orgânica.
D. Agentes vasodilatadores como o alprostadil apesar de demonstrarem menor eficácia que os inibidores da PDE-5, são amplamente utilizados devido à conveniência de administração e baixa incidência de priapismo.

QUESTÃO 23. No conceito de injúria renal aguda é certo dizer:

A. Consiste no estágio 1 de IRA na KDIGO 2012.
B. Aumento da creatinina >= 0,3 mg/dl em 12h
C. Aumento da creatinina >= 2 vezes a basal, a qual é conhecida nos 7 dias anteriores.
D. Aumento da creatinina >= 2 vezes a basal, a qual é presumida.

QUESTÃO 24. Qual desses pacientes tem menor risco para injúria renal aguda?

A. Em uso de diurético
B. Idoso
C. Diabético

D. Alérgico a penicilina

QUESTÃO 25. A doença renal policística autossômica dominante tipo 1

A. Ocorre por mutação no gene PKD2
B. Ocorre por mutação no cromossomo 4
C. É a doença policística renal mais comum.
D. Acomete mais mulheres que homens.

QUESTÃO 26. Na hiponatremia dilucional:

A. O sódio está baixo por perda de sódio na urina
B. Um exemplo é a doença renal crônica
C. O sódio está baixo por redistribuição da água para o terceiro espaço
D. O melhor tratamento é o uso de tiazídicos.

QUESTÃO 27. Drenagem linfática da próstata é, principalmente, para os linfonodos obturadores e ilíacos interno raramente, esta drenagem é para os linfonodos:

A. inguinais profundos.
B. pré-sacrais.
C. inguinais superficiais.
D. retroperitoneais.
E. do hilo renal.

QUESTÃO 28. Na realização da uretrotomia interna para uma estenose de uretra peniana, a complicação mais frequente é

A. recorrência da estenose.
B. hemorragia.
C. extravasamento de líquidos para os tecidos periesponjosos.
D. disfunção erétil.
E. formação de fístulas espongiocavernosas.

QUESTÃO 29. A principal diferença da ressecção transuretral da próstata bipolar para a monopolar é o menor risco de

A. estenose de colo, com necessidade de retratamento.
B. disfunção erétil.
C. sangramento peroperatório.
D. estenose de uretra.
E. incontinência urinária.

QUESTÃO 30. A respeito dos pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica com uso de CO2 para insuflação, com mais hora de duração, assinale a opção que indica em qual deles deve ser feito o controle gasométrico por algum depois do fim da anestesia, devido ao risco de hipercapnia.

A. Naqueles com DPOC.
B. Naqueles com asma leve.
C. Naqueles com insuficiência cardíaca.
D. Naqueles com cirurgias com duração de mais de 3 horas.
E. Em todos os pacientes submetidos a cirurgia renal.

QUESTÃO 31. O indivíduo transplantado renal têm maior risco de desenvolver câncer, devido à imunossupressão cr paciente, o órgão em que mais raramente ocorrerá câncer é o(a):

A. Fígado.
B. Rim.
C. Bexiga.
D. Próstata.
E. Pênis.

QUESTÃO 32. A presença de glândulas pequenas e atípicas na biópsia prostática, implica em:

A. nova biópsia, imediatamente.
B. utilizar a imuno-histoquímica para marcadores de células basais.
C. fazer ressonância magnética multiparamétrica.
D. nova biópsia em 2 meses.
E. prostatectomia radical.

QUESTÃO 33. Fármacos utilizados no tratamento da bexiga hiperativa podem provocar os sintomas listados a seguir, com a **EXCEÇÃO** de um. Assinale-o.

A. Boca seca.
B. Constipação intestinal.
C. Piora do glaucoma.
D. Hipertensão arterial.
E. Alterações cognitivas.

QUESTÃO 34. Durante uma prostatectomia radical de resgate, após radioterapia pélvica, é observada uma lesão retal de 2 cm Assinale a opção que indica a conduta mais segura.

A. Reparo imediato em dois planos.
B. Colostomia apenas.
C. Reparo imediato em dois planos e sonda retal.
D. Interrupção da cirurgia, reparo em dois planos e bloqueio hormonal.
E. Reparo imediato em dois planos e colostomia.

QUESTÃO 35. No paciente idoso com hematúria e tabagista, define

A. o sangramento como glomerular.
B. o sangramento como caliceal.
C. indica a necessidade de cistoscopia.
D. indica a realização de citologia urinária.
E. não indica a origem do sangramento.

QUESTÃO 36. Sobre o paciente com micro hematúria, assinale a opção que indica o fator que não é importante em termos de
risco de malignidade associada.

A. Tabagismo.
B. Irradiação pélvica prévia.
C. Exposição a corantes.
D. História familiar de hematúria.
E. Idade acima de 35 anos.

QUESTÃO 37. A neoplasia prostática afeta mais comumente qual zona prostática respectivamente:

A. Zona periférica
B. Zona de transicional
C. Zona central
D. Zona peri-uretral
E. Estroma fibromuscular

QUESTÃO 38. A úlcera de Hunner refere-se à:

A. Cistite eosinofílica
B. Cistite glandular
C. Cistite intersticial
D. Cistite cística
E. Cistite tuberculosa

QUESTÃO 39. Qual o exame de primeira linha para o diagnóstico de câncer de próstata:

A. O exame retal digital (ERD) X
B. A análise do antígeno específico da próstata (PSA)
C. Ressonância magnética de próstata
D. Ultra-sonografia transretal
E. A combinação de ERD e PSA

QUESTÃO 40. Para o câncer de próstata de muito baixo risco qual tratamento é recomendado:

A. Prostatectomia radical
B. Radioterapia
C. Vigilância ativa
D. Quimioterapia
E. Hormonioterapia

QUESTÃO 41. Qual a mais frequente complicação de cirurgia de próstata:

A. Disfunção erétil
B. Incontinência urinária
C. Incontinência fecal
D. Fístula urinária
E. Hematúria

QUESTÃO 42. Paciente de sexo masculino, 26 anos, com vida sexual ativa (várias parceiras nos último meses), apresentando adenomegalia inguino/femoral direta, progressiva, com aparecimento de sinais flogisticos, drenando secreção purulenta, espontaneamente através de vários pontos e com sinal do sulco (separação dos nódulos linfáticos inflamados da região inguinal dos da femoral, permanecendo-os acima e abaixo do ligamento de Poupart), já apresentando dor e dificuldade para defecar, com fistulização retal. Nega ter tido lesões ulceradas no pênis (sic). Para confirmar a hipótese clínica mais correta para esta situação, dentre os exames abaixo, qual seria o mais indicado e confirmaria o diagnóstico?

A. Bacterioscopia pelo Gram de secreção do bulbão, com ênfase a pesquisa de diplococos Gram negativos, intra e extracelulares.
B. Pesquisa de Clamidia na secreção do bulbão, através, por exemplo, de

Imunofluorescência direta da secreção ou pesquisa por reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para Clamidia.

C. Pesquisa de corpúsculo de Donovan (em secreção corada pelo Leishman ou biópsia corada pelo Giemsa).
D. Pesquisa de bacilos Gram negativos através de Bacterioscopia pelo Gram da secreção drenada do bulbão ou Cultura para Haemophilus ducreyi

QUESTÃO 43. Paciente de 36 anos de idade, feminina, apresentando queda de cabelo, dores articulares e dor no corpo e nas últimas semanas vem apresentando "inchaço" e edema de membros inferiores. O exame Fator Anti Nuclear (FAN) apresentou-se positivo, com título de 1280 e padrão nuclear pontilhado fino. O seu EAS apresentou o seguinte resultado

Exame Físico/Químico
COR - Amarelo escuro (V.R:Am.citrino)
CHEIRO - "Sui Generis" (V.R:"Sui Gen")
ASPECTO - Lig. Turvo (V.R:Límpido)
DEPÓSITO - moderado (V.R: Ausente)
DENSIDADE - 1025 (V.R: 1015 a 1025)
pH - 6.0 (V.R:ácido)
NITRITO - Negativo (V.R:Negativo)
PROTEÍNAS - 2800 mg/dL(V.R: 30 mg/dL)
GLICOSE 0 mg/dL (V.R: 0 mg/dl)
CORPOS CETONICOS - Ausente (V.R-Aus.)
UROBILINOGÊNIO - 1mg/dL (V.R:1)
BILIRRUBINA - Ausente (V.R: Ausente).
HEMÁCIA - Presente(+/4+) (V.R: Aus.)
HEMOGLOBINAS - Presente(V.R: Ausente)

Exame Microscópico
LEUCÓCITOS - 15.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
MUCO - Presente(++/4+)
HEMÁCIAS TOTAL - 20.000/mL (V.R: até 10.000/ml)
Hm.ISOMÓRFICAS - 15.000/mL
Hm.DISMÓRFICAS - 5.000/mL (V.R:5% das Hm.Total)
Cel.UROTELIAIS - 15.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
Cel.TUBULARES - 8.000/mL (V.R: até 1.500/mL)
CRISTAIS-de oxalato de cálcio (+/4+)
CILINDROS HIALINOS - 4000/mL (até 1750/mL)
OUTROS CILINDROS - Gordurosos: 2000/mL (V.R: 0)
NO SORO: COLESTEROL: 340 mg/dL (V.R:<200 mg/dL)
ALBUMINA: 2.9 mg/dL (V.R:4.5-5.5mg/dL)

Considerando a exposição acima, com estes dados, responda que enfermidade melhor explicaria estes achados clínicos/laboratoriais?

A. Síndrome nefrítica-Glomerulonefrite Aguda (GNDA)
B. Síndrome nefrótica-Nefropatia lúpica
C. Síndrome nefrítica-Nefropatia lúpica
D. Síndrome nefrótica-Glomerulonefrite Aguda (GNDA)

QUESTÃO 44. Em um paciente internado com suspeita de sepsis, qual exame deve ser solicitado para avaliar uma possível IRA (Escolha a melhor alternativa dentre as abaixo)?

A. Ácido úrico sérico
B. Uréia sérica
C. NGAL
D. Nitrogênio Ureico Sérico (BUN)

QUESTÃO 45. Qual paciente com doença renal crônica na classificação KDIGO tem maior chance de morrer?

A. G2A1
B. G5A3
C. G4A2
D. G3A3

QUESTÃO 46. Qual dessas fórmulas é a mais recomendada atualmente para cálculo da taxa de filtração glomerular em <u>adultos</u>?

A. Cockcroft-Gault
B. CKD-EPI
C. MDRD
D. CKD-EPI 2021
E. Schwartz

QUESTÃO 47. Qual dessas fórmulas é a mais recomendada atualmente para cálculo da taxa de filtração glomerular em <u>crianças</u>?

A. Cockcroft-Gault
B. CKD-EPI
C. MDRD
D. CKD-EPI 2021
E. Schwartz

QUESTÃO 48. Na nefropatia por lesões mínimas (nefrose lipoídica) as células mais afetadas são:

A. Endoteliócitos
B. Mesangiócitos
C. Podócitos
D. Histiócitos

QUESTÃO 49. De acordo com a fisiopatologia que acomete as doenças glomerulares, escolha o diagnóstico que melhor relaciona fisiopatologia e doença, respectivamente:

A. Depósito de imunocomplexo na luz do capilar glomerular - Glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa.
B. Lesão da membrana basal glomerular associada a anticorpos anti-membrana basal - Doença por Lesão Mínima.
C. Lesão da membrana basal glomerular associada a anticorpo anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA) Glomerulopatia membranosa.
D. Depósito de imunocomplexo na membrana basal glomerular com apagamento difuso dos podócitos - Glomerulonefrite pós estreptocócica (GNPE).

QUESTÃO 50. Paciente do sexo feminino, 25 anos, procura atendimento com queixa de edema peri-orbital, diminuição da diurese, urina escura, cefaleia, escotomas visuais, embaçamento visual, dispneia progressiva. Ao exame fisico encontra-se hipertensa (PA 220/140 mmHg), edema periorbital importante e estertores pulmonares bilaterais. Traz exames de outro serviço que mostram FAN+ 1:320, padrão pontilhado fino, complemento C3 e C4 consumidos, anti- DNA reagente, creatinina 1,8 mg/dL, EAS com hematúria, proteinúria, leucocitúria e cilindros hemáticos. Suas principais hipóteses diagnósticas sindrômica e etiológica são respectivamente:

A. Síndrome Nefrótica - Glomerulonefrite membranosa idiopática
B. Síndrome Nefrótica- Glomeruloesclerose segmentar e focal
C. Síndrome Nefritica - Nefrite lúpica (glomerulonefrite proliferativa)
D. Glomerulonefrite rapidamente progressiva - Síndrome do Bom Pastor.

QUESTÃO 51. Paciente do sexo masculino, 52 anos inicia quadro compatível com síndrome nefrótica, e encaminhado a biópsia renal e realização de exames. O resultado da biópsia renal mostra membrana basal glomerular espessada na coloração por hematoxilina-eosina (HE) e presença de espículas (spikes) na coloração pela prata. Realiza também pesquisa de anti-PLA2R sérico que veio positiva, com títulos elevados. De acordo com estes dados, sua principal hipótese diagnóstica é:

A. Doença por lesão mínima
B. Nefropatia membranosa primária
C. Glomeruloesclerose segmentar e focal
D. Glomerulonefrite membranosa secundária

QUESTÃO 52. Paciente com diagnóstico recente de HIV, com carga viral elevada e CD4 baixo, procura serviços médicos devido quadro compatível com síndrome nefrótica onde foi submetido a biópsia renal. Das formas de doença glomerular associada ao HIV, destaca-se a:

A. Doença por lesão mínima
B. Glomerulonefrite membranoproliferativa
C. Doença de Berger (nefropatia por IgA)
D. Glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF colapsante)

QUESTÃO 53. Homem de 56 anos com creatinina alta há 4 meses (para determinar Doença Renal Crônica as alterações devem ser >= 3 meses), creatinina = 4,0mg/dL (valor relativo normal = 0.4 a 1.2 mg/dL). Qual o diagnóstico provável?

A. Injúria Renal Aguda.
B. Doença Renal Crônica.
C. Rins normais.

D. Doença Renal Aguda.

QUESTÃO 54. Marque a alternativa certa quanto ao diabetes e o rim:

A. Na nefropatía diabética a microalbuminúria está acima de 300mcg/mg de creatinina.
B. Na doença renal do diabetes, se a taxa de filtração glomerular estiver acima de 100ml/min/1.73m25C, esse diagnóstico não é confirmado.
C. Na glomerulopatia diabética ocorre a hialinose de arteríolas aferentes, poupando as arteríolas eferentes.
D. O último estágio da doença renal do diabetes é atingido pela minoria dos diabéticos.

QUESTÃO 55. Em um paciente adulto com múltiplos cistos renais, a maior chance de diagnóstico é:

A. Esclerose tuberosa.
B. Doença renal policística autossômica dominante.
C. Rim em esponja medular.
D. Doença renal policística autossômica recessiva.

QUESTÃO 56. No paciente grande queimado, qual destes distúrbios eletrolíticos que você espera encontrar?

A. Hiponatremia HIPOVOLÊMICA
B. Hipernatremia HIPERVOLÊMICA
C. Hiponatremia HIPERVOLÊMICA
D. Hipernatremia HIPOVOLÊMICA

QUESTÃO 57. Na necrose tubular aguda, a sobrevida do paciente é

A. Maior na medida em que avança na classificação do KDIGO
B. Maior na medida em que ocorre comprometimento de outros órgãos
C. Menor na pré-renal que na renal
D. Menor na anúria que na não oligúrica.

QUESTÃO 58. Paciente de 22 anos de idade, com síndrome urêmica, hipertenso, oligúrico. Fez exames que mostram ureia plasmática = 320mg/dl e creatinina 22 mg/dl. Outros exames deverão com maior probabilidade mostrar.

A. Hipernatremia
B. Hipercalemia
C. Alcalose metabólica
D. Hipomagnesemia.

QUESTÃO 59. Paciente hipertenso, com TFG = 22ml/min/1.73m2, a qual é reduzida há anos, apresenta anemia, hemoglobina = 8 g/dl. O que pode contribuir para essa anemia?

A. Aumento da ligação do ferro às metahemoglobinas
B. Diminuição pelo fígado da liberação de hepcidina.
C. Uso de anti-inflamatórios não hormonais.
D. Intoxicação por vitamina B12.

QUESTÃO 60. Na síndrome cardiorrenal tipo 1 encontramos:

A. Alteração aguda da função renal levando a insuficiência cardíaca
B. Alteração sistêmica afetando ao mesmo tempo rim e coração
C. Alteração cardíaca aguda levando a disfunção renal
D. Alteração renal crônica levando a comprometimento cardíaco

QUESTÃO 61. Quanto à sobrevivência na doença renal crônica terminal

A. A diálise peritoneal oferece maior sobrevida que a hemodiálise
B. O paciente diabético apresenta sobrevida semelhante ao de glomerulonefrite crônica.
C. O transplante renal oferece maior quantidade de vida que a diálise.
D. No transplante renal intervivos a sobrevida é menor que no cadavérico.

QUESTÃO 62. Na doença mineral óssea que acomete o portador de doença renal crônica terminal, a osteomalácia é devido a

A. Intoxicação pelo alumínio
B. Hiperparatiroidismo terciário
C. Iatrogenia por excesso de vitamina D e análogos

D. Deficiência de cálcio

QUESTÃO 63. A furosemida:

A. Inibe a bomba Na-K-ATPase basolateral
B. Bloqueia o canal de K luminal
C. Bloqueia o cotransportador Na-K-2Cl luminal
D. Diminui a permeabilidade a fons dos espaços intercelulares

QUESTÃO 64. Os estudos laboratoriais de uma mulher hipertensa (160/110 mmHg) mostram níveis séricos de potássio muito baixo (2,7 mEq/L) e alto nível de sódio e H2CO3. A associação de Espironolactona + Hidroclorotiazida será a mais adequada nessa paciente.

A. Espironolactona + Hidroclorotiazida
B. Furosemida + clorotiazida
C. Hidroclorotiazida + Glicerina
D. Manitol + Acetazolamida

QUESTÃO 65. A nefropatia medicamentosa ocasionada pelo uso constante de analgésicos e anti-inflamatórios é um dos principais problemas enfrentados por pacientes portadores de doenças crônicas de origem inflamatória, os quais fazem tratamento à base destes medicamentos. Em relação à nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios, assinale a alternativa CORRETA.

A. Apenas os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) não seletivos para COX-2 são capazes de desencadear a nefropatia induzida por anti-inflamatórios.
B. A nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios ocorre por uma redução da produção dos eicosanóides prostaglandina E2 e prostaciclina no rim, os quais estão envolvidos na manutenção da homeostase do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular.
C. A nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios ocorre por um excesso deposição de metabólitos inativos destes medicamentos na membrana de filtração do glomérulo.
D. Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 66. Em relação ao tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), assinale a alternativa CORRETA.

A. Para a redução do volume prostático é indicado o uso de fármacos inibidores da enzima 5a redutase que é responsável pela hidrólise do hormônio di-hidrotestosterona. Desta forma ocorrerá uma redução na liberação de fatores de crescimento e aumento (consequentemente) da proliferação celular no tecido prostático.
B. O tratamento dos sintomas do trato urinário inferior na HPB é feito a partir da utilização dos antagonistas dos receptores a1-adrenérgicos, tendo como efeito principal o relaxamento do colo da bexiga e uretra prostática.
C. Os antagonistas dos receptores a1-adrenérgicos que possuem maior seletividade para os subtipos de receptores a1A e a1C, não apresentam os efeitos adversos de hipotensão ou ejaculação retrógrada.
D. Todas as alternativas estão corretas

QUESTÃO 67. Sobre a Doença Renal Policística:

A. Mutação no gene PKD2 é mais frequente que em PKD1
B. O alvo da osmolalidade urinária é de 100 mOsm/KgH2O para diminuir o crescimento dos cistos
C. A tipo 1 é mais benigna que a tipo 2
D. As células dos cistos apresentam mutação nós dois alelos dos genes PKD

QUESTÃO 68. Exemplos de IRA Pré-Renal:

A. Rabdomiólise, vômitos e diarreia
B. Trombose de veia renal, infarto agudo do miocárdio e vômitos
C. Hiperplasia prostática benigna, infarto agudo do miocárdio e diarreia

D. Insuficiência cardíaca, diarreia e vômitos

QUESTÃO 69. Bactéria mais frequente na Infecção do Trato Urinário:

A. E. coli
B. Proteus mirabilis
C. Klebsiella sp
D. Pseudomona sp

QUESTÃO 70. Na verdadeira hematúria glomerular o teste de dismorfismo eritrocitário mostra alterações de forma utilizando:

A. Microscópio de imunofluorescência
B. Microscópio óptico
C. Microscópio eletrônico
D. Microscópio de contraste de fase

QUESTÃO 71. Causa mais frequente de litíase urinária:

A. Estruvita
B. Oxalato de fósforo
C. Oxalato de cálcio
D. Ácido úrico

QUESTÃO 72. Qual antibiótico que tem menor resistência bacteriana na ITU?

A. Sulfametoxazol + Trimetoprima
B. Amoxicilina
C. Nitrofurantoína
D. Ciprofloxacino

QUESTÃO 73. Classificação G3bA2 ta TFG e microalbuminúria corresponde a

A. TFG 30-49; albumina 30-300
B. TFG 70-90; albumina <30
C. TFG 15-30; albumina >300
D. TFG 30-44/ albumina 30-300

QUESTÃO 74. A classificação KDOQI da Lesão renal aguda foi estabelecida para:

A. Homogeneizar os critérios diagnósticos de LRA
B. Escalonar o risco de mortalidade da LRA
C. Auxiliar nos critérios de indicação de terapia de substituição da função renal
D. Todos os itens acima

QUESTÃO 75. Paciente de 65 anos, sexo feminino, com antecedente de Câncer de estômago há 02 anos, evoluiu com síndrome nefrótica. A biópsia renal da paciente mostra espessamento da membrana basal glomerular sem proliferação capsular ou presença de crescentes. O diagnóstico baseado nas informações é:

A. Glomerulonefrite por lesão mínima
B. Glomeruloesclerose segmentar e focal
C. Membranosa
D. Membranoproliferativa

QUESTÃO 76. Paciente de 6 anos, sexo feminino, com presença de edema há 02 dias, cansaço, dispneia, com urina escura e avermelhada. Refere ter tido histórico de amigdalite purulenta há 3 meses atrás. Por essas informações, qual o diagnóstico mais provável e sua respectiva conduta:

A. Glomerulonefrite pós estreptocócica, uso de diuréticos
B. Nefrite lúpica, uso de corticóides
C. Glomerulonefrite rapidamente progressiva, uso de IECA
D. Vasculite renal, uso de imunossupressor

QUESTÃO 77. Qual a principal causa metabólica de litíase urinária

A. Hipercalciúria primária
B. Hiperoxalúria
C. Cistinúria
D. Hipomagnesúria

QUESTÃO 78. Qual afirmação está ***incorreta*** sobre os fármacos Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil

A. Comida gordurosa inibe a absorção de Sildenafil e Vardenafil, mas não de Tadalafila
B. O prejuízo visual é mais comum na Sildenafil do que na Vardenafil e Tadalafil
C. A maior meia vida plasmática é de Tadalafil
D. Mialgia e dor lombar é menos comum na Tadalafil

QUESTÃO 79. Qual afirmação está incorreta sobre os fármacos Finasterida e Dutasterida

A. Finasterida diminui menos a DHT plasmática que Dutasterida
B. Finasterida diminui de 20 a 30% o volume da próstata enquanto Dutasterida diminui 26%
C. Disfunção erétil é igualmente comum na FInasterida e na Dutasterida e é aproximadamente de 8%
D. Diminuição do libido é 3 vezes mais maior na Finasterida que na Dutasterida

QUESTÃO 80. Marque a alternativa incorreta em relação aos antagonistas alfa-1 utilizados no tratamento da HPB:

A. Os novos antagonistas alfa-1, como a tansulosina e a alfuzosina provocam menos hipotensão e podem ser administradas uma vez ao dia.
B. A tansulosina tem sido o mais utilizado atualmente.
C. Existe a possibilidade de tratamento combinado da HPB: tansulosina + finasterida.
D. A terazosina, por ser um antagonista alfa-1-C, é o fármaco mais potente para o tratamento da HPB.

QUESTÃO 81. Sobre escroto agudo, assinale a correta:

A. Ultrassonografia com doppler é exame que nada ajuda na investigação.
B. Torção do cordão espermático (ou de testículo) é o diagnóstico a ser excluído no atendimento do paciente com dor testicular aguda. Sabe-se que quase a totalidade dos testículos é preservada quando a exploração cirúrgica é realizada em até 6h do início do quadro.
C. Em caso de abordagem cirúrgica em que confirme a torção testicular, a fixação do testículo contralateral não é necessária.
D. Traumas contusos de testículo não podem ter indicação de tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 82. Hidronefrose antenatal é um achado comum em ultrassonografias obstétricas. Acerca dessas alterações responda a correta:

A. VUP é causa de hidronefrose antenatal. Não pode cursar com IRC.
B. RVU - nem todos os casos são cirúrgicos. Tratamento visa impedir ITU febril.
C. JUP é a mais frequente. Nunca é cirúrgico.
D. Terapias endoscópicas não podem ser usadas para tratamento de RVU.

QUESTÃO 83. Sobre hipospádia:

A. A grande maioria é anterior ou distal (até 50% dos casos).
B. Hipospádias posteriores (penoescrotal, escrotal ou perineal) são de correção mais simples que as distais.
C. Há apenas uma técnica cirúrgica para correção de hipospádia.
D. Hipospádias posteriores não tem relação com infertilidade.

QUESTÃO 84. A dosagem de antígeno prostático específico (PSA) tem aumentado sua importância na prática médica. Sobre o PSA:

A. Não se altera com infecção urinária.
B. PSA na hiperplasia prostática benigna aumenta 0.8 ng/g de tecido hiperplásico por ano; enquanto no câncer de próstata aumenta cerca de 3 vezes mais.
C. Relação PSA livre/total > 20% é sugestiva de malignidade.
D. Uso de inibidor da 5 alfa-redutase diminui em 50 % o valor do PSA após 1 ano de tratamento.

QUESTÃO 85. Acerca da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) assinale a correta: ?

A. Paciente com sintomas de esvaziamento e próstata maior que 40 gramas é indicação de tratamento cirúrgico.
B. Uretrocistografia retrógrada e miccional faz diagnóstico de obstrução prostática.

C. Paciente castrado antes da puberdade não desenvolve HPB.
D. Fluxo urinário > 150 ml indica descompensação detrusora.

QUESTÃO 86. Reconstrução urinária pós cistectomia radical

A. Qualquer paciente pode ser candidato a neobexiga ao invés de derivações externas
B. Distúrbios hidroeletrolíticos são pouco frequentes no P.O.
C. Neobexiga tem mesmo padrão de contração e esvaziamento
D. Preserva porção distal do íleo devido absorção de B12

QUESTÃO 87. Indicações absolutas de intervenção cirúrgica no trauma renal

A. Hematoma retroperitoneal pulsátil ou em expansão
B. Lesão de alto grau
C. Extravasamento de contraste
D. Estadiamento incompleto

QUESTÃO 88. Bactérias comuns em ITU

A. Pseudomonas e Staphilo em gestantes
B. Staphylo saprophticus cresce rápido e diagnóstico é fácil
C. S. aureus dissemina hematogênico
D. E beta hemolítico grupo B é comum nosocomial

QUESTÃO 89. São fatores predisponentes para ITU

A. Incontinência urinária na infância
B. Alteração hormonal em mulheres jovens
C. Início precoce da vida sexual em homens.
D. Uso recente de antibióticos

QUESTÃO 90. Qual a zona mais afetada no câncer de próstata?

A. Zona central
B. Zona anterior
C. Zona periférica
D. Zona de transição.

QUESTÃO 91. Paciente com adenocarcinoma de próstata, estádio T3bN0M0. O tumor é:

A. palpável no toque retal, invade vesícula seminal, sem metástase ganglionar ou a distância.
B. impalpável no toque retal, invade um lado da próstata, com metástase ganglionar ou a- distância
C. impalpável no toque retal, invade músculo elevador do ânus, sem metástase ganglionar ou a distância.
D. palpável no toque retal, invade os dois lados da próstata, com metástase ganglionar ou a distância.

QUESTÃO 92. Qual das seguintes afirmações é verdadeira (V) ou falsa (F)?

A. (F) A principal causa de trauma renal é a lesão por arma de fogo.
B. (V) A queda "a cavaleiro" leva ao trauma de uretra anterior.
C. (F) Cistografia é exame de escolha no diagnóstico do trauma de bexiga.
D. (V) No trauma de bexiga, a causa mais frequente é por traumatismo contuso.
E. (V) Em cerca de 20% dos traumas renais, o tratamento é cirúrgico.

QUESTÃO 93. Paciente, sexo masculino, 19 anos, vida sexual ativa (várias parceiras nos últimos meses). Notou aparecimento de lesão papular, cinco dias após relação sexual com desconhecida, sendo que esta lesão ulcerou, apresentou bases irregulares, não endurecidas, extremamente dolorosas, e apareceram em pele de região próxima também (“lesões em beijo”) e depois passou a apresentar adenopatia inguinal, unilateral, que passou a drenar secreção purulenta, por único ponto de secreção purulenta. Para confirmar sua hipótese clínica, dentre os exames abaixo, qual seria o mais indicado?

A. Pesquisa de corpúsculo de donovan (em secreção corada pelo Leishman ou biópsia corada pelo Giemsa)

B. Pesquisa de bacilos gram negativos através de bacterioscopia pelo gram de secreção drenada do bulbão.
C. Pesquisa de Clamidia na secreção do bulbão, através, por exemplo, de IFD ou por PCR para chlamydia.
D. Bacterioscopia pelo gram da secreção do bulbão, com ênfase a pesquisa de diplococos gram negativos, intra e extracelulares.

QUESTÃO 94. Os diuréticos têm sido utilizados no tratamento da hipertensão arterial há mais de 40 anos e permanecem como uma das cinco classes de medicamentos anti-hipertensivos de primeira linha. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a classe de diurético e seu mecanismo de ação:

A. Os diuréticos tiazidicos atuam na alça de Henle. Aumentam o fluxo plasmático renal e o fluxo plasmático medular e papilar. O principal efeito colateral é a hipernatremia
B. Os diuréticos de alça atuam nos segmentos espessos da alça de Henle. Promovem diurese intensa e rápida, redução da PA e também potencializa a ação de outros hipotensores
C. Os diuréticos osmóticos atuam no ducto coletor. Possuem a propriedade de inibir a excreção de K+ e inibe a reabsorção de hidrogênio
D. Os inibidores da anidrase carbônica atuam no túbulo contorcido distal e causam diminuição na excreção urinária de sódio, potássio, bicarbonato e fosfato.

QUESTÃO 95. O tratamento da disfunção erétil começa com a identificação e controle dos fatores de risco. Além disso, o médico poderá prescrever medicamentos que irão contribuir para a melhoria na qualidade das ereções e consequentemente na atividade sexual do paciente. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a classe de medicamento e seu mecanismo de ação no tratamento da disfunção erétil.

A. Os inibidores da PDE5 atuam impedindo a degradação do GMPc, o que levará ao bloqueio dos canais de K+ e abertura dos canais de Ca2+ e consequentemente ao relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso.
B. A fentolamina, um antagonista não-seletivo dos receptores a-adrenérgicos, é amplamente utilizado no tratamento da disfunção erétil, uma vez que impede a vasoconstrição da musculatura lisa do corpo cavernoso ocasionada por ação do sistema nervoso autônomo simpático.
C. O Alprostadil, um análogo sintético da PGE1, pertence à classe de medicamentos de segunda linha do tratamento da disfunção erétil, devendo ser administrado por via sublingual minutos antes da relação sexual.
D. Todas as alternativas estão erradas.

QUESTÃO 96. Em relação ao tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), assinale a alternativa CORRETA.

A. Para redução do volume prostático é indicado o uso de fármacos inibidores da enzima 5a redutase que é responsável pela hidrólise do hormônio di-hidrotestosterona. Desta forma ocorrerá uma redução na liberação de fatores de crescimento e consequentemente no aumento da proliferação celular no tecido prostático.
B. O tratamento dos sintomas do trato urinário inferior na HPB é feito a partir da utilização de fármacos antagonistas dos receptores a1-adrenérgicos, tendo como efeito principal o relaxamento do músculo detrusor da bexiga.
C. A fármacos antagonistas dos receptores a1-adrenérgicos que possuem maior seletividade para os subtipos de receptores al A e alC, não apresentam os efeitos adversos de hipotensão ou ejaculação retrógrada.
D. Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 97. Na glomerulopatia membranosa primária os depósitos eletrodensos são:

A. Subepiteliais
B. Subendoteliais
C. Submembranosos
D. Intraendoteliais

QUESTÃO 98. Na glomerupatia membranosa secundária, como o Lúpus Eritematoso Sistêmico, os depósitos eletrodensos são:

A. Subepiteliais
B. Subendoteliais
C. Submembranosos
D. Interendoteliais

QUESTÃO 99. Sobre a Litotripsia Extracorpórea (LECO), julgue as afirmativas abaixo e marque a correta.

A. A LECO deve ser indicada para cálculos calicinais sintomáticos ou maiores que 5 mm e menores que 20 mm. renais
B. Cálculos com densidade topografia acima de 1000 UH tem melhor resultado com a LECO
C. Alterações na coagulação sanguínea não contraindicam o procedimento.
D. Poderá ser realizado mesmo na presença de obstrução e infecção.

QUESTÃO 100. Sobre a litíase urinária assinale a alternativa incorreta:

A. O cálculo mais comum é o de oxalato de cálcio
B. A dor na cólica é causada pela distensão da cápsula renal
C. A maioria dos cálculos são radiotransparentes
D. Os cálculos de urato amorfo ou ácido úrico são em geral transparentes

QUESTÃO 101. Qual é a metástase hematogênica mais frequente do câncer de próstata?

A. Hepática.
B. Pulmonar.
C. Óssea.
D. Renal.

QUESTÃO 102. O tempo médio para espermatogênese testicular, incluindo transporte e maturação do espermatozoide pelo epidídimo, é de:

A. 01 semana
B. 30 dias
C. 60 dias
D. 90 dias

QUESTÃO 103. De acordo com os parâmetros seminais do manual da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2010, as alterações morfológicas, com base nos parâmetros de Kruger, com morfologia normal menor do que 4%, recebem o nome de:

A. Astenozoospermia
B. Hipospermia
C. Teratozoospermia
D. Criptozoospermia

QUESTÃO 104. Em relação à epidemiologia do câncer de bexiga, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. É mais comum em mulheres do que homens, com incidência estimada de 3:1.
B. O Tabagismo é o principal fator de risco.
C. Tem maior incidência na sexta e sétima décadas de vida.
D. A exposição a aminas aromáticas e agentes químicos industriais também são fatores de risco a serem considerados.

QUESTÃO 105. Em relação aos subtipos histológicos do câncer de bexiga, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. O subtipo urotelial corresponde a mais de 90% das neoplasias vesicais.
B. Em geral, o carcinoma de células escamosas (CEC) e o adenocarcinoma têm prognóstico pior, por doença avançada no momento do diagnóstico.
C. A infecção crônica da bexiga por Schistosoma haematobium é fator de risco para surgimento de adenocarcinoma,bem como os

processos inflamatórios crônicos vesicais, como cálculos urinários, infecções do trato urinário e uso de cateter vesical de demora por período prolongado.

D. Deve-se sempre excluir a possibilidade de outros sítios primários de adenocarcinoma de bexiga, como reto, mama, próstata e ovário.

QUESTÃO 106. São indicação de exames de imagem no trauma renal, exceto:

A. Hematúria macroscópica.
B. Hematuria microscópica + PAS < 90 mmHg
C. Trauma com mecanismo de desaceleração
D. Mais de 50 hemácias na urina/campo em crianças

QUESTÃO 107. São características específicas da urina que protegem contra infecções urinárias, exceto:

A. Alta Osmolalidade
B. Concentração de ureia
C. Presença de ácidos orgânicos
D. pH baixo

QUESTÃO 108. São fatores predisponentes de infecções urinárias, exceto:

A. Uretra feminina curta
B. Atividade sexual
C. Modificações hormonais na mulher pré menopausa
D. Predisposição genética

QUESTÃO 109. Sobre escroto agudo, assinale a correta:

A. Ultrassonografia com doppler de testiculo é exame que nada acrescenta na investigação de escroto agudo
B. Torção de cordão espermático (ou torção de testículo) é o diagnóstico a ser excluído no atendimento do paciente com dor testicular aguda. Sabe-se que quase a totalidade dos testículos é preservada quando a exploração cirúrgica é realizada em até 24 horas após o início do quadro.
C. Em caso de abordagem cirúrgica em que se confirme torção testicular, a fixação do testículo contralateral é necessária
D. Trauma contusos de testiculo não pode ter indicação de tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 110. Sobre Hidronefrose perinatal, assinale a alternativa correta.

A. Válvula de uretra posterior é causa de hidronefrose antenatal. Está doença pode cursar com insuficiência renal crônica.
B. Refluxo vesicoureteral (RVU) é a condição na qual ha fluxo retrógrado de urina da bexiga para o trato urinário superior. Pode ser classificado pela uretrocistografia em 4 graus. Nem todos os casos são cirúrgicos. A principal finalidade do tratamento conservados é impedir o surgimento de infecção urinária febril.
C. Obstrução da junção ureteropiélica (JUP) é a causa mais frequente de obstrução do trato urinário superior na população e seu tratamento quase nunca é cirúrgico.
D. Terapias endoscópicas não podem ser usadas para tratamento de refluxo vesicoureteral.

QUESTÃO 111. Hipospádia é uma anomalia do sistema urogenital muito frequente. Sobre esta condição é correto:

A. A grande maioria dos casos é proximal.
B. Hipospadias penoeserotal, escrotal ou perineal são de correção mais simples do que apresentações distais.
C. Existe apenas uma técnica cirúrgica descrita para tratamento de hipospadias.
D. Hipospadias posteriores podem ter relação com infertilidade.

QUESTÃO 112. Em relação ao PSA (antígeno prostático específico) assinale a alternativa CORRETA:

A. O PSA se altera com infecção urinária.

B. O aumento do PSA na HPB é de 0,8 ng/grama de tecido hiperplásico/ano, enquanto no Ca de próstata o aumento é 3 vezes maior.
C. A relação PSA total/ PSA livre acima de 20 por cento é sugestiva de malignidade.
D. O uso de inibidores de 5 redutase diminui em 10 por cento e valor do PSA após 1 ano de tratamento.

QUESTÃO 113. Em relação à HPB, marque a alternativa correta:

A. A uretrocistográfica retrógrada e miccional faz o diagnóstico de obstrução prostática
B. Indivíduos castrados antes da puberdade desenvolvem HPB
C. Fluxo urinário maior que 15 ml/s é indicativo de descompensação detrusora
D. Paciente com sintomas de esvaziamento e próstata maior que 40gr é indicado podem ser conduzidos sem cirurgia

QUESTÃO 114. Qual dos seguintes sintomas não é considerado de armazenamento (irritativo):

A. Noctúria
B. Urgência miccional
C. Polaciúria
D. Sensação de esvaziamento incompleto

QUESTÃO 115. Marque a alternativa incorreta quanto a comparação entre finasterida e dutasterida.

A. A finasterida diminui menos a DHT plasmática do que a dutasterida.
B. A finasterida reduz o volume prostático (em seis meses de tratamento) em torno de 20% a 30%, enquanto que a dutasterida reduz em 26%.
C. A incidência de disfunção erétil em pacientes tratados com dutasterida e a finasterida é a mesma, ou seja, em torno 8%.
D. A diminuição da libido em pacientes tratados com finasterida é o triplo quando comparada com a dutasterida.

QUESTÃO 116. Uma mulher de 25 anos tem início súbito de febre, mal-estar e náusea. Exame da urina de rotina mostra proteína 1+, ausência de cetonas, ausência de glicose e sangue 4+, com cilindros hemáticos ao exame microscópico. Há acentuada hipercelularidade glomerular por microscopia óptica, com neutrófilos nas alças capilares glomerulares. A microscopia por imunofluorescência revela deposição granular de IgG e C3 nas membranas basais capilares glomerulares. À microscopia eletrônica, observam-se "gibas" subepiteliais eletrondensas. O diagnóstico mais provável é:

A. Síndrome de Goodpasture.
B. Glomerulonefrite membranosa.
C. Glomerulonefrite pós-infecciosa.
D. Diabetes mellitus.

QUESTÃO 117. Um homem saudável de 72 anos sente dificuldade crescente à micção. Ele precisa levantar várias vezes durante a noite em razão de sensação de urgência, mas a cada vez o volume de urina é pequeno. Ele tem dificuldade em iniciar e interromper a micção. Este problema se agravou nos últimos anos. O nível sérico de PSA está levemente aumentado, mas estável durante esse período. Biópsia da próstata provavelmente revelará:

A. Nódulos hiperplásicos de estroma e glândulas revestidas por duas camadas de epitélio.
B. Glândulas mal diferenciadas revestidas por uma única camada de epitélio, com fusão de ácinos.
C. Células inflamatórias com predomínio de neutrófilos e abscessos no estroma e em glândulas.
D. Múltiplas áreas de inflamação granulomatosa caseosa.

QUESTÃO 118. Uma criança de 2 anos possui uma massa no testiculo esquerdo com 2,5cm de diâmetro e bem circunscrita. Histologicamente, essa massa demonstra lâminas de células com glândulas mal definidas compostas de células cubóides, algumas das quais contendo glóbulos hialinos eosinofílicos. A análise encontra microcistos e estruturas glomeruloides primitivas. É demonstrada AFP (alfa fetoproteína) no citoplasma das células neoplásicas por imuno-histoquímica. A criança provavelmente tem:

A. Coriocarcinoma.
B. Seminoma.
C. Tumor do saco vitelino.
D. Teratoma.

QUESTÃO 119. Paciente com 60 anos de idade, diabética há 10 anos, hipertensa também há 10 anos, com taxa de filtração glomerular 19 ml/min/1,73 m2SC. Nega hematuria, nega cólicas ou dores, nega uso de anti-inflamatórios, nega alterações cutâneas ou articulares. A taxa de filtração glomerular há 1 ano era de 23 ml/min/1,72m2SC. Microalbuminúria 10 mg/g de creatinina, EAS mostra apenas glicosúria e densidade de 1008. Como deve ser o aspecto mais provável dos rins à ultrassonografia?

A. Rins policísticos.
B. Rins de aspecto normal
C. Rins pequenos
D. Hidronefrose bilateral

QUESTÃO 120. Quanto às doenças císticas renais é correto afirmar:

A. A DRPAD tipo I é menos frequente que a tipo 2
B. A DRPAD apresenta fenótipo menos intenso que a tipo 2
C. A DRPAD tipo 1 ocorre por alterações genética no cromossomo 16
D. A DRPAD tipo 2 ocorre mais frequentemente no sexo feminino.

QUESTÃO 121. Paciente de 35 anos, masculino, ex-tabagista, está internado na UTI em insuficiência respiratória devido à hemorragia pulmonar aguda, insuficiência renal aguda oligúrica e hipertensão arterial. Iniciado tratamento hemodialítico de urgência, anti-hipertensivos e investigação de causas secundárias para o quadro clínico. Laboratorialmente apresentava EAS com leucocitúria, hematúria e proteinúria com presença de cilindros hemáticos, proteinúria de 24 horas 0,5 g/24 horas, creatinina sérica= 6,5 mg/dL, ANCAS negativos e anticorpo anti-membrana basal reagente. O principal diagnóstico sindrômico e etiológico neste caso são:

A. Síndrome nefrótica e lesão mínima primária.
B. Síndrome nefrótica e nefropatia por IgA.
C. Síndrome nefrítica e glomeruloesclerose segmentar e focal.
D. Síndrome nefrítica e síndrome de goodpasture.

QUESTÃO 122. Correlacione as complicações da síndrome nefrótica de acordo com a proteína perdida e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

1 - perda urinária de albumina;
2 - perda urinária de imunoglobulinas e fatores do complemento;
3 - perda urinária de anti-trombina III;
4 - perda urinária da proteína transportadora de vitamina D.

( ) Trombose venosa profunda
( ) Edema
( ) Peritonite bacteriana espontânea
( ) Hiperparatireoidismo

A. 1-3-4-2
B. 3-1-2-4
C. 2-1-3-4
D. 3-1-4-2

QUESTÃO 123. Criança de oito anos, após diagnóstico de impetigo há 15 dias, dá entrada no pronto-socorro com quadro de dispneia, cansaço, edema, hipertensão arterial, diminuição do volume urinário e coloração avermelhada na urina há 48 horas. A fisiopatologia envolvida no surgimento da hipertensão arterial e edema neste caso são:

A. Aumento da filtração glomerular com maior reabsorção tubular de água
B. Diminuição da filtração glomerular e hipervolemia
C. Necrose tubular aguda secundário ao quadro infeccioso e oligúria
D. Aumento da permeabilidade da membrana basal glomerular e hipovolemia

QUESTÃO 124. Três maratonistas tiveram estratégias diferentes durante a corrida. O primeiro decidiu por tomar água para repor as perdas e ganhou 2Kg após a corrida. O segundo resolveu tomar água com gás e também ganhou 3Kg após a corrida. O terceiro resolveu não tomar líquidos durante a corrida. Quais as alterações possíveis do sódio encontradas no final da corrida, respectivamente em cada corredor?

A. Hiponatremia, hiponatremia, hiponatremia.
B. Hiponatremia, hipernatremia, hipernatremia.
C. Hipernatremia, hipernatremia, hipernatremia.
D. Hiponatremia, hiponatremia, hipernatremia.

QUESTÃO 125. São exemplos de LRA pré-renal:

A. Rabdomiólise, diarréia e vômitos
B. Trombose de veia renal, infarto agudo do miocárdio e vômitos
C. Hiperplasia prostática benigna, infarto agudo do miocárdio e diarreia
D. Insuficiência cardíaca, grande queimado e vômitos

QUESTÃO 126. Na lesão renal aguda por necrose tubular aguda a concentração do sódio urinário está elevada por vários motivos, entre eles:

A. Ocorre uma maior reabsorção de água por vazamento retrógrado
B. O sódio é menos reabsorvido por perda da polaridade das células tubulares renais
C. O sódio é mais secretado por ação da aldosterona
D. Há uma maior ação do hormônio antidiurético reabsorvendo água

QUESTÃO 127. Na fisiopatologia da nefropatia diabética encontramos:

A. Deficiência na formação dos AGES (Advanced Glycation End Products)
B. Aumento da formação da matriz mesangial.
C. Proliferação acentuada de podócitos.
D. Inibição da formação de sorbitol intracelular

QUESTÃO 129. Os IECA e BRA são renoprotetores porque?

A. Aumentam o fluxo plasmático renal
B. Aumentam a resistência da arteríola eferente
C. Aumentam a resistência da arteríola aferente
D. Aumentam o calibre da arteríola eferente

QUESTÃO 130. Na lesão renal aguda deve-se evitar o uso de

A. Anti-inflamatórios não hormonais
B. IECA e BRA
C. Anfotericina
D. Todas as respostas

QUESTÃO 131. Qual a principal causa de Doença Renal Crônica dialítica no Brasil?

A. Diabete melito
B. Doença renal policística
C. Hipertensão arterial sistêmica
D. Urolitíase

QUESTÃO 132. Paciente de 36 anos de idade, feminina, apresentando queda de cabelo, dores articulares e dor no corpo e nas últimas semanas vem apresentando "inchaço" e edema de membros inferiores. O exame Fator Anti Nuclear (FAN) apresentou-se positivo, com título de 1280 e padrão nuclear pontilhado fino. O seu EAS apresentou o seguinte resultado

Exame Físico/Químico

COR - Amarelo escuro (V.R:Am.citrino)
CHEIRO - "Sui Generis" (V.R:"Sui Gen")
ASPECTO - Lig. Turvo (V.R:Límpido)
DEPÓSITO - moderado (V.R: Ausente)
DENSIDADE - 1025 (V.R: 1015 a 1025)
pH - 6.0 (V.R:ácido)
NITRITO - Negativo (V.R:Negativo)
PROTEÍNAS - 2800 mg/dL(V.R: 30 mg/dL)
GLICOSE 0 mg/dL (V.R: 0 mg/dl)
CORPOS CETONICOS - Ausente (V.R-Aus.)
UROBILINOGÊNIO - 1mg/dL (V.R:1)
BILIRRUBINA - Ausente (V.R: Ausente).
HEMÁCIA - Presente(+/4+) (V.R: Aus.)
HEMOGLOBINAS - Presente(V.R: Ausente)

Exame Microscópico
LEUCÓCITOS - 15.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
MUCO - Presente(++/4+)
HEMÁCIAS TOTAL - 20.000/mL (V.R: até 10.000/ml)
Hm.ISOMÓRFICAS - 15.000/mL
Hm.DISMÓRFICAS - 5.000/mL (V.R:5% das Hm.Total)
Cel.UROTELIAIS - 15.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
Cel.TUBULARES - 8.000/mL (V.R: até 1.500/mL)
CRISTAIS-de oxalato de cálcio (+/4+)
CILINDROS HIALINOS - 4000/mL (até 1750/mL)
OUTROS CILINDROS - Gordurosos: 2000/mL (V.R: 0)
NO SORO: COLESTEROL: 340 mg/dL (V.R:<200 mg/dL)
ALBUMINA: 2.9 mg/dL (V.R:4.5-5.5mg/dL)

Considerando a exposição acima, com estes dados, responda que enfermidade melhor explicaria estes achados clínicos/laboratoriais?

A. Síndrome nefrítica-Glomerulonefrite Aguda (GNDA)
B. Síndrome nefrótica-Nefropatia lúpica
C. Síndrome nefrítica-Nefropatia lúpica
D. Síndrome nefrótica-Glomerulonefrite Aguda (GNDA)

QUESTÃO 133. Paciente de 26 anos de idade, feminina, apresentando febre, dor na região lombar e disúria. Foi solicitado um EAS que apresentou:
Exame Físico/Químico
COR: amarelo-escura (V.R: amarelo-citrino)
CHEIRO - "Sui Generis" (V.R:"Sui Generis")
pH - 6.5 (V.R: ácido)
ASPECTO: turvo (V.R: límpido)
DEPÓSITO - Moderado (V.R: Ausente)
DENSIDADE: 1022 (V.R: 1015 a 1025)
GLICOSE: 0 mg/dL (V.R: 0 mg/dL)
NITRITO: Positivo (V.R: negativo)
UROBILINOGÊNIO < 1 mg/dL (V.R: <1 mg/dL)
CORPOS CETÔNICOS: Ausentes (V.R: Ausente)
HEMÁCIAS: Presente (+++/4+) (V.R: ausentes)

Exame Microscópico
LEUCÓCITO - 145.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
PROTEINA - 300mg/dL (V.R: <30mg/dL)
BILIRRUBINA - Ausente (V.R: Ausente)
HEMOGLOBINA - Presente(V.R: Ausente)
HEMÁCIAS TOTAL - 500.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
Hm. ISOMÓRFICAS - 200.000mL
Hm. DISMÓRFICAS - 400.000/mL (V.R: <5% das Hm. Total)
Cel. TUBULARES - 80.000/mL (V.R: até 1.500/mL)
Cel. UROTELIAIS - 20.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
CILINDROS HIALINOS - 2000/mL (V.R: até 1750/mL)
OUTROS CILINDROS - Hemático: 50.000/mL (V.R: 0).
Leucocitário- 100.000/mL (V.R: 0)
MUCO: Presente (++/4+)
CRISTAIS - Ausentes
Considerando a exposição acima, com estes dados, responda:
Que enfermidade melhor explicaria estes achados clínicos/laboratoriais?

A. Infecção do Trato Urinário (ITU) Baixa/Cistite
B. Infecção do Trato Urinário (ITU) Alta/ Pielonefrite
C. Glomerulonefrite Aguda (GNDA)
D. Nefropatia lúpica

QUESTÃO 134. Paciente de sexo masculino, 19 anos, com vida sexual ativa (várias parceiras nos último meses), notou o aparecimento de lesão papular, cinco dias após relação sexual com desconhecida, sendo que esta lesão ulcerou, apresentado bases irregulares, não endurecidas,extremamente dolorosas, que apareceram em pele de região próxima também ("lesões em beijo") e depois passou a apresentar adenopatia inguinal, unilateral, que passou a drenar secreção purulenta, por único ponto de drenagem. Para confirmar a hipótese clínica que deve ser feita, dentre os exames abaixo, qual seria o mais indicado?

A. Pesquisa de bacilos Gram negativos através de Bacterioscopia pelo Gram de secreção drenada do bulbão.
B. Pesquisa de Clamidia na secreção do bulbão, através, por exemplo, de imunofluorescência direta ou por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para Chlamydia.
C. Bacterioscopia pelo Gram da secreção do bulbão, com ênfase a pesquisa de diplococos Gram negativos, intra e extracelulares.
D. Pesquisa de corpúsculo de Donovan (em secreção corada pelo Leishman ou biópsia corada pelo Giemsa)

QUESTÃO 135. Paciente, 70 anos, acompanha com urologista por hiperplasia prostática benigna. Está em tratamento clínico otimizado e possui ressonância nuclear magnética de próstata e biópsia de próstata com resultados tranquilizadores. Considerando os mecanismos que levaram à hiperplasia prostática benigna, assinale a afirmativa correta.

A. A testosterona atua nas células do estroma prostático, estimulando a secreção de fatores de crescimento e a consequente proliferação glandular.
B. A 5-alfa-redutase realiza a conversão de dihidrotestosterona em testosterona, atuando, então, como fator estimulador na hiperplasia prostática benigna.
C. A 5-alfa-redutase inibe a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, atuando, então, como fator protetor para hiperplasia prostática benigna.
D. A di-hidrotestosterona atua nas células do estroma prostático, estimulando a secreção de fatores de crescimento e a consequente proliferação glandular.

QUESTÃO 136. Paciente, sexo masculino, 60 anos, queixa-se de oito meses de noctúria e aumento considerável de frequência miccional. Relata, ainda, de impacto significativo em sua qualidade de vida. Negou perda de peso no período. Possui ressonância nuclear magnética de próstata indicando órgão com, aproximadamente, 35 gramas e sem sinais de malignidade. Considerando o quadro clínico, assinale a afirmativa correta.

A. O tamanho da próstata se relaciona diretamente com o grau de obstrução e sintomas.
B. O tamanho da próstata não se correlaciona diretamente com o grau de obstrução e sintomas.
C. O quadro clínico é pouco condizente com o exame de imagem realizado, devendo-se repetir a ressonância nuclear magnética ou realizar biópsia de próstata.
D. A síndrome do lobo mediano, onde o aumento do segmento prostático exerce um efeito semelhante a uma válvula na bexiga, não deve ser considerada nessa situação.

QUESTÃO 137. Paciente, sexo masculino, 60 anos, queixa-se de noctúria, esforço miccional, enfraquecimento do jato e gotejamento. Refere que os sintomas representam impacto significativo em sua qualidade de vida. Possui seguimento regular com urologista, que registra em prontuário um IPSS de 24 na atual avaliação. Está há seis meses em uso de doxazosina com discreta melhora dos sintomas. Realizou USG de bexiga com resíduo pós-miccional de 70 ml. Ressonância nuclear magnética de próstata indica órgão com, aproximadamente, 30 cm3 e lobo

mediano aumentando. Considerando o quadro clínico, qual a melhor conduta terapêutica?

A. Indicar prostatectomia radical.
B. Indicar início de Alfa-1-bloqueador.
C. Indicar ressecção endoscópica de próstata.
D. Associar anticolinérgico à terapêutica em vigor.

QUESTÃO 138. Paciente, sexo masculino, 75 anos, vem encaminhado a urologista após atendimento em pronto-socorro de hospital terciário. Refere quadro de hematúria macroscópica com dois dias de evolução. Foram realizados exames laboratoriais e tomografias, assim como sondagem vesical de demora e irrigação com soro fisiológico gelado por 24 horas. Recebeu alta com manutenção da sondagem e encaminhamento para equipe de urologia. Relata, ainda, antecedente pessoal de tabagismo pesado e hipertensão em uso de losartana. Apresenta exames laboratoriais sem alterações e tomografia computadorizada de abdômen e pelve com protocolo de urotomografia que acusou lesão vegetante vesical com invasão da próstata e envolvimento de múltiplos linfonodos em cadeia pélvica. Tomografia de crânio e tórax sem alterações dignas de nota. Assinale a classificação TNM de tal paciente.

A. T4a N2 M0
B. T4b N3 M1
C. T4a N3 M0
D. T4b N2 M0

QUESTÃO 139. Paciente, sexo masculino, 65 anos, vem encaminhado para urologista após diagnóstico de neoplasia de bexiga. Na investigação inicial, apresentava tumoração de 3,5 cm na parede lateral direita da bexiga. Tomografia de tórax; abdômen; e, pelve de estadiamento sem outras lesões ou linfonodomegalias. Foi então submetido à ressecção transuretral de bexiga. Na primeira reavaliação após a cirurgia, apresenta relatório de anatomia patológica, indicando carcinoma urotelial de alto grau sem invasão da camada muscular própria. Não possui demais comorbidades além do tabagismo. Demais exames pré-operatórios sem alterações. Qual a melhor opção terapêutica?

A. Radioterapia local.
B. Indicar nova RTUb.
C. Iniciar protocolo de BCG intravesical.
D. Indicar nova RTUB e iniciar protocolo de BCG intravesical.

QUESTÃO 140. Paciente, sexo masculino, 55 anos, assintomático, procura urologista para iniciar seguimento e prevenção. Está assintomático e negou antecedentes pessoais relevantes. Ao exame físico, está em bom estado geral, próstata de, aproximadamente, 35 gramas, fibroelástica e sem nodulações. PSA de 7 ng/dL. Foi submetido à biópsia de próstata, com diagnóstico de Adenocarcinoma Gleason 7 (4+3). Qual a melhor alternativa terapêutica?

A. Ter vigilância ativa.
B. Indicar a prostatectomia radical; a cintilografia óssea é obrigatória.
C. Indicar a prostatectomia radical; a cintilografia óssea é uma indicação relativa.
D. O paciente deve ser estadeado com ressonância magnética de pelve e próstata, além de cintilografia com tecnécio para se confirmada doença localizada, indicar prostatectomia radical.

QUESTÃO 141. Paciente, sexo masculino, 80 anos, retorna para avaliação de urologista com resultado de biópsia de próstata. Está assintomático e possui como antecedentes pessoais fibrilação atrial; hipertensão; e, hipotireoidismo com tratamento adequado e efetivo. Está em bom estado geral, com próstata de, aproximadamente, 45 gramas e região endurecida em base de lobo direito. Apresenta PSA = 8,5 ng/dL; biópsia indicando adenocarcinoma Gleason 3+3 em dois fragmentos no total de 20. A proporção de tumor nas lâminas foi de 10% em cada fragmento. Qual a melhor conduta?

A. Radioterapia.
B. Vigilância ativa.
C. Bloqueio hormonal.

D. Prostatectomia sem linfadenectomia.

QUESTÃO 142. Os diuréticos de alça (furosemida) são os agentes mais eficazes disponíveis para induzir excreção de água e eletrólitos. Seu mecanismo de ação é ou são:
( ) Bloquear o simportador de Na-K-2Cl no ramo ascendente da alça de Henle e chegada de mais Na' ao túbulo distal com perda da urinária de Na e água.
( ) Aumentam a atividade da enzima conversora de angiotensina (ECA).
( ) Antagonista dos receptores de angiotensina
( ) Antagonista dos receptores da aldosterona.
A sequência correta é:

A. F-V-F-F.
B. F-F-V-F.
C. F-F-F-V.
D. V-F-F-F.

QUESTÃO 143. Os estudos laboratoriais de uma mulher hipertensiva (160/110 mmHg) mostram níveis séricos de potássio muito baixo (2,7 mEq/L) e alto nível de sódio e HCO3. A associação de _____ será a mais adequada nessa paciente.

A. Espironolactona + Hidroclorotiazida
B. Furosemida + clorotiazida
C. Hidroclorotiazida + Glicerina
D. Manitol + Acetazolamida

QUESTÃO 144. A nefropatia medicamentosa ocasionada pelo uso constante de analgésicos e anti-inflamatórios é um dos principais problemas enfrentados por pacientes portadores de doenças crônicas de origem inflamatória, os quais fazem tratamento à base destes medicamentos. Em relação à nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios, assinale a alternativa CORRETA.

A. Apenas os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos para COX-2 são capazes de desencadear a nefropatia induzida por anti-inflamatórios.
B. A nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios ocorre por uma redução da produção dos eicosanóides prostaglandina E2 e prostaciclina no rim, os quais estão envolvidos na manutenção da homeostase do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular.
C. A nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios ocorre por um excesso deposição de metabólitos inativos destes medicamentos na membrana de filtração do glomérulo.
D. Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 145. Paciente de 29 anos de idade, feminina, apresentando febre, dor na região lombar e disúria. Foi solicitado um EAS que apresentou: Exame Físico/Químico
COR: amarelo-escura (V.R: amarelo-citrino)
CHEIRO - "Sui Generis" (V.R:"Sui Generis")
pH - 6.5 (V.R: ácido)
NITRITO: Positivo (V.R: negativo)
UROBILINOGÊNIO < 1mg/dL (V.R: < 1 mg/dL)
CORPOS CETÔNICOS: Ausentes (V.R: Ausente)
HEMÁCIAS: Presente (+++/4+) (V.R: ausentes)

Exame Microscópico
LEUCÓCITO - 145.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
ASPECTO: turvo (V.R: límpido)
DEPÓSITO - Moderado (V.R: Ausente)
DENSIDADE: 1022 (V.R: 1015 a 1025)
GLICOSE: 0 mg/dL (V.R: 0 mg/dL)
PROTEINA - 300mg/dL (V.R: <30mg/dL)
BILIRRUBINA - Ausente (V.R: Ausente)
HEMOGLOBINA - Presente(V.R: Ausente)
HEMÁCIAS TOTAL-500.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
Hm. ISOMORFICAS - 200.000mL
Hm. DISMÓRFICAS - 400.000/mL (V.R: <5% das Hm. Total)
Cel. TUBULARES - 80.000/mL (V.R: até 1.500/mL)
Cel. UROTELIAIS - 20.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
CILINDROS HIALINOS - 2000/mL (V.R: até 1750/mL) OUTROS CILINDROS - Hemático: 50.000/mL (V.R: 0).

Leucocitário- 100.000/mL (V.R: 0)
MUCO: Presente (++/4+)
CRISTAIS - Ausentes
Considerando a exposição acima, com estes dados, que enfermidade melhor explicaria estes achados clínicos/laboratoriais?

A. Infecção do Trato Urinário (ITU) Alta/ Pielonefrite 1
B. Infecção do Trato Urinário (ITU) Alta/ Pielonefrite
C. Glomerulonefrite Aguda (GNDA)
D. Nefropatia lúpica

QUESTÃO 146. Paciente de sexo masculino, 23 anos, com vida sexual ativa (várias parceiras nos último meses), notou o aparecimento de lesão papular, cinco dias após relação sexual com desconhecida, sendo que esta lesão ulcerou, apresentado bases irregulares, não endurecidas,extremamente dolorosas, que apareceram em pele de região próxima também ("lesões em beijo") e depois passou a apresentar adenopatia inguinal, unilateral, que passou a drenar secreção purulenta, por único ponto de drenagem.
Para confirmar a hipótese clínica que deve ser feita, dentre os exames abaixo, qual seria o mais indicado?

A. Pesquisa de bacilos Gram negativos através de Bacterioscopia pelo Gram da secreção drenada do bulbão.
B. Pesquisa de Clamidia na secreção do bulbão, através, por exemplo, de imunofluorescência direta ou por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para Clamidia.
C. Bacterioscopia pelo Gram da secreção do bulbão, com ênfase a pesquisa de diplococos Gram negativos, intra e extracelulares. D) Pesquisa de corpúsculo de Donovan (em secreção corada pelo Leishman ou biópsia corada pelo Giemsa)
D. Devido ao aumento de consultas regulares (preventivas) sua incidência tem diminuído.

QUESTÃO 147. Paciente de 6 anos de idade, masculino, apresentando edema bipalpebral matutino, com urina avermelhada há dois dias. No exame físico, edema da face e membros inferiores. PA = 160 x 105 mmHg. A mãe refere que a criança teve lesões de pele com "bolhas com pus" há duas semanas, que regrediu espontaneamente, sem deixar cicatriz (sic). Seu EAS apresentou:

Exame Físico/Químico
COR: amarelo-escura (V.R: amarelo-citrino)
CHEIRO - "Sui Generis" (V.R:"Sui Generis")
pH - 6.5 (V.R: ácido)
NITRITO: Negativo (V.R: negativo)
UROBILINOGÊNIO < 1mg/dL (V.R: <1 mg/dL)
CORPOS CETÔNICOS: Ausentes (V.R: Ausente)
HEMÁCIAS: Presente (+++/4+) (V.R: ausentes)

Exame Microscópico
LEUCÓCITO - 25.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
ASPECTO: turvo (V.R: límpido)
DEPÓSITO - Moderado (V.R: Ausente)
DENSIDADE: 1022 (V.R: 1015 a 1025)
GLICOSE: 0 mg/dL (V.R: 0 mg/dL)
PROTEINA - 280mg/dL (V.R: <30mg/dL)
BILIRRUBINA - Ausente (V.R: Ausente)
HEMOGLOBINA - Presente(V.R: Ausente)
HEMÁCIAS TOTAL - 500.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
Hm. ISOMORFICAS - 200.000mL
Hm. DISMÓRFICAS - 400.000/mL (V.R: <5% das Hm. Total)
Cel. TUBULARES - 80.000/mL (V.R: até 1.500/mL)
Cel. UROTELIAIS - 20.000/mL (V.R: até 10.000/mL)
CILINDROS HIALINOS - 2000/mL (V.R: até 1750/mL)
OUTROS CILINDROS - Hemático: 20.000/mL (V.R: 0)
MUCO: Presente (++/4+)
CRISTAIS - Ausentes
NO SORO: COLESTEROL: 190mg/dL (V.R:<200 mg/dL)
ALBUMINA:4.9mg/dL (V.R:4.5-5.5mg/dL)
Considerando a exposição acima, com estes dados, que enfermidade melhor explicaria estes achados clínicos/laboratoriais?

A. Infecção do Trato Urinário (ITU)
B. Tumor Renal
C. Glomerulonefrite Aguda (GNDA)
D. Nefropatia lúpica

QUESTÃO 148. Paciente com 55 anos de idade, diagnóstico recente pela tomografia computadorizada, de um nódulo renal sólido com 4,0 cm de diâmetro, com realce pelo contraste, exofítico, em pólo superior rim esquerdo. Qual a melhor conduta a ser tomada?

A. Radioterapia externa
B. Nefrectomia parcial laparoscópica
C. Por ser um tumor no estádio T2a, está indicada a nefrectomia radical.
D. Por estar afastada a possibilidade de lesão maligna, fazer acompanhamento clínico anual.

QUESTÃO 149. Em relação ao câncer renal, é correto afirmar:

A. Realizar atividades físicas, evitar tabagismo e redução da obesidade são medidas de prevenção primária
B. Representam 5-8 % das neoplasias de todas as neoplasias.
C. O tipo histológico papilar é o subtipo histológico mais comum.
D. Devido ao aumento de consultas regulares (preventivas) sua incidência tem diminuído

QUESTÃO 150. Sobre litíase urinária, assinale a afirmativa CORRETA.

A. Os cálculos coraliformes preenchem todo o sistema pielocalicinal e ureter.
B. Cálculos de ácido oxalato de cálcio podem ser dissolvidos com medicação.
C. Os cálculos de ácido úrico são radiotransparentes.
D. Os cálculos de estruvita são compostos de oxalato de cálcio e ácido úrico.

QUESTÃO 151. Sobre varicocele, assinale a afirmativa CORRETA.

A. Todos os pacientes devem ser tratados,mesmo se assintomáticos.
B. O tratamento clínico resolve a maioria dos casos.
C. por se tratar de uma doença venosa, é sempre bilateral.
D. O diagnóstico é clínico, podendo ser complementado com o ultrassom / Doppler de bolsa escrotal.

QUESTÃO 152. No tratamento do cálculo renal:

A. A litotripsia externa apresenta melhores resultados que a abordagem ureteroscópica nos cálculos de ureter distal.
B. Os resultados da litotripsia externa tem relação com o índice de massa corpórea do paciente (distância pele - cálculo).
C. A litotripsia externa apresenta melhores resultados que a cirurgia percutânea nos cálculos menores que 2cm, independentemente da composição do cálculo.
D. A litotripsia externa apresenta os mesmos resultados que a cirurgia percutânea nos cálculos de até 2 cm, localizados em cálices inferiores.

QUESTÃO 153. Uma condição clínica devastadora, que mesmo quando tratada adequadamente, traz um grande risco de doença renal crônica. Sua suspeita diagnóstica é forte quando no ultrassom ante-natal tem-se: hidronefrose bilateral, oligohidrâmnio e distensão da bexiga.
O texto acima diz respeito a seguinte anomalia:

A. Estenose da junção pieloureteral
B. Refluxo vesico ureteral
C. Válvula de uretra posterior
D. Hidrocele comunicante

QUESTÃO 154. Em relação às opções terapêuticas propostas para cálculo de ureter distal é correto que:

A. a cirurgia laparoscópica é a primeira opção de tratamento.

B. litotripsia extracorpórea e a ureteroscopia retrógrada têm taxas de sucesso em torno de 80%.
C. ureteroscopia é superior à litotripsia extracorpórea
D. cirurgia aberta ainda é a mais empregada.

QUESTÃO 155. Qual zona da próstata é mais frequentemente acometida pelo câncer da próstata?

A. zona central.
B. zona anterior.
C. zona periférica.
D. zona de transição

QUESTÃO 156. Não é correto dizer no conceito de injúria renal aguda:

A. Volume urinário < 0,5 ml/Kg/h por 12 horas
B. Aumento da creatinina ≥ 0,3 mg/dl em 48h
C. Aumento da creatinina ≥ 1,5 vezes a basal, a qual é conhecida nos 7 dias anteriores.
D. Aumento da creatinina ≥ 1,5 vezes a basal, a qual é presumida.

QUESTÃO 157. Qual desses pacientes têm menor risco para injúria renal aguda?

A. Em uso de diurético
B. Idoso
C. Diabético
D. Alérgico a penicilina

QUESTÃO 158. A doença renal policística autossômica dominante tipo 1

A. Ocorre por mutação no gene PKD2
B. Ocorre por mutação no cromossomo 4
C. Tem o fenótipo pior que o outro tipo.
D. Acomete mais mulheres que homens.

QUESTÃO 159. Na hiponatremia dilucional:

A. O sódio está baixo por perda de sódio na urina
B. Um exemplo é a doença renal crônica
C. O sódio está baixo por redistribuição da água para o terceiro espaço
D. O melhor tratamento é o uso de tiazídicos.

QUESTÃO 160. Paciente de 35 anos, masculino, ex-tabagista, é internado na UTI em insuficiência respiratória devido à hemorragia pulmonar aguda, injúria renal aguda oligúrica e hipertensão arterial. Iniciado tratamento hemodialítico de urgência, anti-hipertensivos e investigação de causas secundárias para o quadro clínico. Laboratorialmente apresentava EAS com leucocitúria, hematúria e proteinúria com presença de cilindros hemáticos, proteinúria de 24 horas= 0,5 g/24 horas, creatinina sérica=5,5 mg/dL, ANCAS negativos e anticorpo anti-membrana basal reagente. O principal diagnóstico sindrômico e etiológico neste caso são:

A. síndrome nefrótica e nefropatia por lesão mínima primária.
B. síndrome nefrótica e nefropatia por IgA.
C. síndrome nefrítica e síndrome de Goodpasture.
D. síndrome nefrítica e glomeruloesclerose segmentar e focal.

QUESTÃO 161. Correlacione as complicações da síndrome nefrótica de acordo com a proteína perdida e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

1 - perda urinária de albumina
2 - perda urinária de imunoglobulinas e fatores do complemento
3 - perda urinária de anti-trombina III
4 - perda urinária da proteína transportadora de vitamina D

( ) trombose venosa profunda
( ) edema
( ) peritonite bacteriana espontânea
( )hiperparatireoidismo

a. 3-1-2-4
b. 2-1-3-4
c. 3-1-4-2
d. 1-3-4-2

QUESTÃO 162. Criança de oito anos, após diagnóstico de impetigo há 15 dias, dá entrada no pronto-socorro com quadro de dispnéia, cansaço, edema, hipertensão arterial, diminuição do volume urinário e coloração avermelhada na urina há 48 horas. A fisiopatologia envolvida no surgimento da hipertensão arterial e edema neste caso são:

A. Aumento da filtração glomerular com maior reabsorção tubular de água
B. Diminuição da filtração glomerular e hipervolemia
C. Necrose tubular aguda secundária ao quadro infeccioso e oligúria
D. Aumento da permeabilidade da membrana basal glomerular e hipovolemia

QUESTÃO 163. Paciente com obesidade mórbida evolui com quadro clínico e laboratorial compatível com síndrome nefrótica e foi submetida à biópsia renal que mostrou alguns glomérulos alterados, com lesões segmentares de esclerose e colapso de alças capilares. Baseado neste laudo da biópsia renal pode-se dizer que se trata de:

A. Doença por lesões mínimas
B. Glomerulonefrite membranoproliferativa
C. Glomerulonefrite membranosa
D. Glomeruloesclerose segmentar e focal

QUESTÃO 164. Assinale a alternativa CORRETA:

A. A correção intempestiva de uma hiponatremia crônica pode levar a edema cerebral.
B. Hipernatremia importante é menos frequente se o paciente tem o mecanismo da sede intacto e livre acesso à água.
C. A mielinólise pontina é a lesão neurológica causada pela correção rápida da hipernatremia.
D. Diabetes insipidus é uma causa comum de hiponatremia.

QUESTÃO 165. Em qual dessas causas de DRC o rim permanece geralmente de tamanho normal?

A. Glomerulonefrite crônica
B. Nefrosclerose hipertensiva benigna
C. Diabetes mellitus
D. Pielonefrite crônica

QUESTÃO 166. Quanto a GNDA pós-estreptocócica é correto afirmar:

A. É mais frequente em crianças abaixo de 2 anos de idade
B. Tem indicação absoluta de hospitalização para melhor manejo da fase aguda
C. Cursa com hematuria microscópica isomórfica
D. O tratamento de escolha para o edema e hipertensão é a restrição hidrossalina e diuréticos.

QUESTÃO 167. Qual exame mostrará mais precisamente danos renais resultantes por infecções urinárias recorrentes em pacientes com refluxo urinário mais avançado?

A. ultra-som
B. urografia excretora
C. cintilografia renal com DTTA
D. cintilografia renal com DMSA
E. tomografia computadorizada

QUESTÃO 168. Diante de um paciente com idade avançada e com imagens radiográficas osteoblásticas em vértebras con bacia, qual exame deve ser realizado inicialmente:

A. Ultra-som transretal da próstata
B. Biópsia transretal da próstata
C. CT helicoidal de abdominal total
D. Biópsia óssea por aspiração
E. Dosagem de PSA

QUESTÃO 169. Na suspeita de ITU amostra de urina mais confiável para o diagnóstico correto é obtida pela:

A. Cateterização uretral após higiene do meato
B. Aspiração do cateter de demora
C. Coleta do jato médio matinal em frasco estéril

D. Aspiração por punção supra-púbica
E. Coleta do jato inicial em frasco estéril

QUESTÃO 170. Em relação à varicocele podemos afirmar que:

1. É encontrada em 10-20% dos homens inférteis
2. A cirurgia proporciona índices de gravidez do 70-80%
3. A presença de dor testicular é indicação para tratamento cirúrgico em todos os casos
4. A presença de varicocele é Indicação da cirurgia para os pacientes portadores da patologia

Podemos afirmar que

A. 1, 2 e 3 estão corretas.
B. 1, 2 e 4 estão corretas.
C. 2 e 4 estão corretas,
D. 2, 3 e 4 estão corretas.
E. 2 e 3 estão corretas.

QUESTÃO 171. Qual dessas é a principal causa de injúria Renal Aguda?

A. Nefrite túbulo-intersticial
B. Necrose cortical
C. Necrose tubular aguda
D. Glomerulonefrite rapidamente progressiva

GABARITO COMENTADO | UROLOGIA E NEFROLOGIA

Apêndice elaborado para as questões do documento **QUESTÕES (ALAN) M2(1).pdf**. As 28 páginas de enunciados encontram-se antes deste apêndice, sem o título editorial e sem anotações externas.

170 questões presentes. A numeração original vai de 1 a 171, porém a questão 128 não consta no arquivo enviado e não foi criada artificialmente.

Critério de correção: **letra** = melhor alternativa identificada; ***** = resposta condicionada a ressalva relevante; **SEM RESPOSTA** = nenhuma alternativa tecnicamente satisfatória; **letras com barra** = mais de uma alternativa compatível ou inválida; **V/F** = sequência de julgamento dos itens.

Gabarito resumido

1: D	13: B	25: C	37: A
2: D	14: D	26: B	38: C
3: A	15: C	27: C	39: E*
4: C	16: A	28: A	40: C
5: C	17: B	29: C	41: A*
6: B	18: B	30: A	42: B
7: D	19: B	31: D	43: B
8: C	20: A	32: B	44: C*
9: D	21: C	33: D*	45: B
10: D	22: C	34: E	46: D
11: A	23: C	35: C	47: E
12: A	24: D	36: D	48: C

49: SEM RESPOSTA	61: C	73: D	85: C
50: C	62: A	74: A*	86: D
51: B	63: C	75: C	87: A
52: D	64: A*	76: A*	88: C
53: B	65: B	77: A	89: D*
54: D	66: B	78: D	90: C
55: B	67: D	79: D*	91: A
56: A*	68: D	80: D	92: F-V-V-V-F
57: D	69: A	81: B	93: B*
58: B	70: D	82: B	94: B
59: C*	71: C	83: A*	95: B*
60: C	72: C*	84: D	96: SEM RESPOSTA

97: A	109: C	121: D	133: B*
98: A*	110: A	122: B	134: A
99: A	111: D	123: B	135: D
100: B/C	112: A	124: D	136: B
101: C	113: D	125: D	137: C
102: D*	114: D	126: B	138: A
103: C	115: D*	127: B	139: D*
104: A	116: C	128: ausente	140: C*
105: C	117: A	129: D	141: B*

106: SEM RESPOSTA	118: C	130: D*	142: D
107: SEM RESPOSTA	119: C*	131: C*	143: A*
108: C	120: C	132: B	144: B
145: A/B	157: D	169: D*	
146: A*	158: C	170: SEM RESPOSTA	
147: C	159: B	171: C	
148: B	160: C		
149: A	161: A		
150: C	162: B		
151: D	163: D		
152: B	164: B		
153: C	165: C		
154: C*	166: D		
155: C	167: D		
156: D*	168: E		

Atenção especial: 33, 39, 41, 44, 49, 56, 59, 64, 72, 74, 76, 79, 83, 89, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 106, 107, 115, 119, 130, 131, 133, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 154, 156, 169, 170. Também há inconsistências ou limitações pontuais em outras questões; todas constam dos respectivos comentários.

COMENTÁRIOS POR QUESTÃO E POR ALTERNATIVA

Os comentários reproduzem a ordem A–E das alternativas existentes. O enunciado integral permanece nas páginas originais imediatamente anteriores a este apêndice. As referências indicadas entre colchetes estão disponíveis ao final.

QUESTÃO 1 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) ureia também decorre do catabolismo de proteínas; dieta não reduz somente creatinina.

B) ureia é intensamente reabsorvida, e creatinina sofre secreção tubular.

C) a creatinina isolada depende de idade, sexo e massa muscular, sendo preferível estimar a TFG.

D) a produção depende da massa muscular e sua concentração tende a aumentar quando cai a TFG.

Ressalva: A relação com a TFG não é linear e sofre influência extrarrenal.

QUESTÃO 2 — Resposta: D | Fontes: R9, R8

A) fígado não é o destino hematogênico predominante.

B) metástase renal não é o padrão mais frequente.

C) pulmões podem ser acometidos, mas menos tipicamente que o esqueleto.

D) a disseminação óssea, frequentemente osteoblástica, é a mais característica.

QUESTÃO 3 — Resposta: A | Fontes: R3, R2

A) perda da polaridade e do transporte tubular prejudica a reabsorção de sódio.

B) aldosterona aumenta reabsorção de Na, não sua secreção.

C) ADH modifica reabsorção de água, não justifica diretamente a natriurese tubular.

D) vazamento retrógrado do filtrado não é maior reabsorção hídrica fisiológica.

QUESTÃO 4 — Resposta: C | Fontes: R12

A) Haemophilus ducreyi causa cancro mole, geralmente úlceras dolorosas, não o quadro típico com sinal do sulco.

B) diplococos Gram-negativos sugerem gonococo, não a linfadenite descrita.

C) LGV por C. trachomatis L1-L3 causa bubões, sinal do sulco e proctite; NAAT/PCR em material adequado é preferível.

D) corpúsculos de Donovan sugerem donovanose, habitualmente úlcera genital crônica sem adenopatia verdadeira.

Ressalva: A confirmação específica de LGV requer genotipagem quando disponível; NAAT comum detecta clamídia, mas não diferencia sorotipos.

QUESTÃO 5 — Resposta: C | Fontes: R3, R7

A) diabetes produz sobretudo alterações crônicas, não este padrão pós-infeccioso.

B) doença anti-MBG revela depósito linear de IgG, não granular com gibas.

C) glomerulonefrite pós-infecciosa cursa com hipercelularidade exsudativa, IgG/C3 granulares e humps subepiteliais.

D) nefropatia membranosa cursa com espessamento da MBG, sem exsudação neutrofílica típica.

QUESTÃO 6 — Resposta: B | Fontes: R5

A) infecção urinária não controlada e obstrução distal sem drenagem contraindicam LECO.

B) cálculos renais sintomáticos selecionados de até 20 mm podem ser tratados, com decisão individual por localização.

C) densidade superior a 1000 UH associa-se a pior fragmentação.

D) coagulopatia não corrigida é contraindicação importante.

Ressalva: A indicação não decorre automaticamente de qualquer cálculo superior a 5 mm.

QUESTÃO 7 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) não é a ação hemodinâmica principal dos IECA/BRA.

B) esses fármacos reduzem, não aumentam, a resistência eferente.

C) mudanças do fluxo plasmático podem ocorrer, mas não definem o mecanismo renoprotetor.

D) a dilatação eferente reduz a pressão intraglomerular e a proteinúria.

Ressalva: Monitorar creatinina e potássio após iniciar ou ajustar.

QUESTÃO 8 — Resposta: C | Fontes: R1

A) polaciúria é sintoma de armazenamento.

B) noctúria é sintoma de armazenamento.

C) sensação de esvaziamento incompleto é sintoma pós-miccional.

D) urgência caracteriza sintomas de armazenamento.

QUESTÃO 9 — Resposta: D | Fontes: R3, R2

A) permeabilidade glomerular alterada não explica hipervolemia com hipovolemia.

B) não existe hiperfiltração nesse quadro nefrítico.

C) não se trata primariamente de necrose tubular por sepse.

D) queda da TFG e retenção de sódio e água provocam edema e hipertensão.

QUESTÃO 10 — Resposta: D | Fontes: R10

A) a fração livre/total baixa, não a razão total/livre maior que 20%, preocupa mais.

B) inibidores da 5-alfa-redutase reduzem PSA aproximadamente 50% em meses.

C) esta relação fixa de incrementos anuais por grama não é critério clínico validado.

D) infecção urinária/prostatite pode elevar transitoriamente o PSA.

QUESTÃO 11 — Resposta: A | Fontes: R3, R2

A) lesões em parte dos glomérulos (focais) e em parte do tufo (segmentares) definem GESF.

B) membranosa apresenta espessamento da membrana basal e depósitos subepiteliais.

C) membranoproliferativa costuma ter hipercelularidade e duplicação da membrana basal.

D) lesão mínima não produz esclerose segmentar focal característica.

Ressalva: Obesidade pode associar-se a GESF secundária.

QUESTÃO 12 — Resposta: A | Fontes: R4

A) achados atípicos para doença renal diabética justificam considerar biópsia.

B) meta pressórica é individualizada, não valor único obrigatório 140/85.

C) albuminúria moderada pode regredir e não determina progressão inevitável.

D) espessamento de MBG ocorre precocemente; hipertrofia pode ocorrer no início.

Ressalva: O título inicial menciona lesões mínimas, mas as alternativas tratam de nefropatia diabética.

QUESTÃO 13 — Resposta: B | Fontes: R3, R7

A) Doppler pode ajudar quando a suspeita é incerta, sem atrasar cirurgia se alta suspeita.

B) após torção confirmada, recomenda-se orquidopexia contralateral.

C) a chance de salvamento é maior nas primeiras 6 horas e cai com atraso; não é quase total até 24 h.

D) trauma contuso com ruptura testicular pode exigir exploração cirúrgica.

QUESTÃO 14 — Resposta: D | Fontes: R3, R7

A) trombose venosa renal é causa intrínseca vascular, embora IAM e vômitos possam causar hipoperfusão.

B) HPB causa obstrução pós-renal.

C) rabdomiólise causa lesão renal intrínseca pigmentária.

D) insuficiência cardíaca, queimaduras com hipovolemia e vômitos causam hipoperfusão renal.

QUESTÃO 15 — Resposta: C | Fontes: R13, R1

A) diabetes é uma causa muito frequente e está empatada com hipertensão no censo brasileiro de 2024.

B) litíase é causa menos comum de falência renal dialítica.

C) hipertensão foi historicamente a primeira causa atribuída no Brasil e hoje empata com diabetes.

D) rins policísticos respondem por fração menor.

Ressalva: Dado histórico: em 2024 HAS e diabetes foram ambas estimadas em 29%; a pergunta deixou de ter resposta única na epidemiologia atual.

QUESTÃO 16 — Resposta: A | Fontes: R1, R2

A) acesso livre à água e sede preservada protegem contra hipernatremia grave.

B) diabetes insípido favorece perda de água livre e hipernatremia.

C) correção rápida da hiponatremia crônica causa desmielinização osmótica, não edema cerebral.

D) desmielinização osmótica relaciona-se à elevação excessivamente rápida do sódio na hiponatremia crônica.

QUESTÃO 17 — Resposta: B | Fontes: R10

A) glândulas malformadas em camada única e fusão acinar sugerem adenocarcinoma.

B) HPB exibe hiperplasia glandular e estromal com camada basal preservada.

C) granulomas caseosos sugerem tuberculose prostática.

D) neutrófilos e abscessos apontam prostatite aguda.

QUESTÃO 18 — Resposta: B | Fontes: R14, R16

A) hipospermia é baixo volume ejaculado.

B) teratozoospermia é percentual anormalmente baixo de formas normais (<4% pelos critérios estritos indicados).

C) criptozoospermia é presença raríssima de espermatozoides, geralmente após centrifugação.

D) astenozoospermia é motilidade abaixo do parâmetro.

Ressalva: Valores de referência evoluíram nas versões da OMS; a terminologia permanece.

QUESTÃO 19 — Resposta: B | Fontes: R7, R19

A) a maioria é distal, não proximal.

B) localização proximal pode dificultar ejaculação intravaginal e estar associada a infertilidade.

C) existem diversas técnicas reconstrutivas.

D) formas proximais são em geral mais complexas de corrigir.

QUESTÃO 20 — Resposta: A | Fontes: R7, R19

A) corpos de Schiller-Duval e positividade para AFP são característicos de tumor do saco vitelino.

B) teratoma mostra tecidos de diferentes linhagens germinativas.

C) coriocarcinoma exibe elementos trofoblásticos e costuma expressar hCG.

D) seminoma tem grandes células germinativas com citoplasma claro e é incomum nessa idade.

QUESTÃO 21 — Resposta: C | Fontes: R10

A) alfa-bloqueadores reduzem tônus, e 5-ARI reduzem DHT, estando correta.

B) a apoptose e seus efeitos clínicos não são o principal mecanismo que sustenta as indicações; redação pouco precisa.

C) inverte os mecanismos: alfa-bloqueadores agem no componente dinâmico e 5-ARI no volume prostático.

D) alfuzosina tem uro-seletividade clínica, mas não seletividade molecular estrita alfa-1A/1D; menor hipotensão não é absoluta.

Ressalva: D também é farmacologicamente imprecisa; C é o erro mais inequívoco.

QUESTÃO 22 — Resposta: C | Fontes: R14

A) ausência de ereção no teste, sem verificar mecanismo, não indica automaticamente injeção intracavernosa.

B) primeira linha costuma ser PDE5 oral, não papaverina/fentolamina.

C) álcool, certos anti-hipertensivos e diuréticos podem contribuir para disfunção erétil.

D) alprostadil exige aplicação invasiva ou intrauretral em formulações próprias e pode causar priapismo.

QUESTÃO 23 — Resposta: C | Fontes: R1, R2

A) LRA abrange estágios 1 a 3, não equivale somente ao estágio 1.

B) elevação de 0,3 mg/dL é avaliada em até 48 horas, não 12 como critério.

C) duplicação da creatinina conhecida em sete dias atende critério de LRA.

D) a duplicação presumida sem delimitação temporal não confirma LRA.

QUESTÃO 24 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) diuréticos podem facilitar hipovolemia, elevando risco em certos cenários.

B) idade avançada é fator predisponente.

C) diabetes associa-se a maior risco de LRA.

D) alergia a penicilina isoladamente não é fator clássico de risco renal.

QUESTÃO 25 — Resposta: C | Fontes: R1, R2

A) PKD2 causa principalmente a forma tipo 2.

B) PKD1 está no cromossomo 16, não 4.

C) a forma tipo 1 é a mais frequente de DRPAD e em geral mais grave.

D) não há predomínio feminino estabelecido.

QUESTÃO 26 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) hiponatremia dilucional decorre de excesso relativo de água, não necessariamente perda urinária de Na.

B) DRC avançada pode reduzir excreção de água livre e ocasionar hiponatremia dilucional.

C) passagem de água ao terceiro espaço não define a diluição plasmática pretendida.

D) tiazídicos podem provocar ou agravar hiponatremia.

QUESTÃO 27 — Resposta: C | Fontes: R10

A) drenagem para inguinais profundos é pouco habitual, mas há vias excepcionais.

B) cadeias pré-sacrais podem participar da drenagem pélvica.

C) drenagem para inguinais superficiais é excepcional.

D) cadeias retroperitoneais podem ser envolvidas por progressão tumoral.

E) linfonodos do hilo renal não compõem a drenagem habitual da próstata.

Ressalva: Escolha C como melhor resposta; a palavra raramente torna A e E também discutíveis se tomada literalmente.

QUESTÃO 28 — Resposta: A | Fontes: R15

A) recorrência de estenose é a limitação mais frequente após uretrotomia interna.

B) sangramento pode ocorrer, mas não é o evento mais comum a longo prazo.

C) extravasamento periesponjoso é possível, menos frequente.

D) disfunção erétil não é a complicação predominante.

E) fístula espongiocavernosa é rara.

QUESTÃO 29 — Resposta: C | Fontes: R10

A) risco de estenose de colo não constitui a diferença mais estabelecida.

B) disfunção erétil não é o principal diferencial.

C) a técnica bipolar diminui sangramento perioperatório e síndrome de RTU por permitir irrigação salina.

D) estenose de uretra pode ocorrer em ambas técnicas.

E) não há redução consistente tão característica de incontinência.

QUESTÃO 30 — Resposta: A | Fontes: R14

A) DPOC reduz reserva ventilatória e facilita retenção de CO2 após pneumoperitônio.

B) asma leve controlada não representa o maior risco comparativo.

C) insuficiência cardíaca isolada não é o fator respiratório mais direto.

D) duração prolongada aumenta absorção de CO2 mas não identifica o paciente mais vulnerável.

E) todo paciente de cirurgia renal não exige gasometria de rotina.

QUESTÃO 31 — Resposta: D | Fontes: R9, R8

A) hepatocarcinoma é relevante no transplantado, conforme fatores de risco e infecções.

B) câncer renal pode aumentar, inclusive em rins nativos.

C) câncer urotelial da bexiga pode aumentar sob imunossupressão.

D) a incidência de câncer prostático não parece tão aumentada por imunossupressão quanto outras neoplasias.

E) câncer peniano relacionado a HPV pode estar aumentado.

Ressalva: Frequências absolutas dependem da população, idade e vigilância; interpretar como risco associado ao transplante.

QUESTÃO 32 — Resposta: B | Fontes: R10

A) biópsia imediata não é o primeiro passo obrigatório diante de foco pequeno suspeito.

B) imuno-histoquímica para células basais, como p63/34betaE12, ajuda a distinguir adenocarcinoma.

C) RM pode complementar estratificação, mas não substitui estudo histológico do foco.

D) repetir em dois meses não é etapa universal obrigatória.

E) prostatectomia radical exige confirmação de malignidade e indicação terapêutica.

QUESTÃO 33 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R10

A) boca seca é comum com antimuscarínicos.

B) constipação é efeito anticolinérgico típico.

C) antimuscarínicos podem piorar glaucoma de ângulo fechado não controlado.

D) hipertensão não é típica dos antimuscarínicos, mas pode ocorrer com mirabegrona, agonista beta-3 também usada para bexiga hiperativa.

E) confusão e prejuízo cognitivo podem ocorrer, sobretudo em idosos.

Ressalva: A questão não tem exceção absoluta se incluir todos os medicamentos atuais, porque mirabegrona pode elevar a PA.

QUESTÃO 34 — Resposta: E | Fontes: R15

A) reparo isolado em pelve irradiada expõe a falha/fístula.

B) colostomia isolada não trata a lesão retal.

C) sonda retal não oferece proteção equivalente a derivação fecal em cenário de alto risco.

D) interrupção e bloqueio hormonal não são solução padrão imediata.

E) reparo e derivação fecal temporária podem ser a opção mais segura na lesão retal em cirurgia de resgate irradiada.

Ressalva: A indicação de colostomia depende de tamanho, contaminação, qualidade tecidual e equipe.

QUESTÃO 35 — Resposta: C | Fontes: R11

A) a história não permite afirmar origem glomerular.

B) não demonstra origem calicial.

C) idoso tabagista com hematúria requer investigação urotelial incluindo cistoscopia.

D) citologia isolada não substitui cistoscopia.

E) verdade que origem não fica definida só pelos fatores de risco, mas não responde à conduta prioritária.

Ressalva: A alternativa E também é literalmente verdadeira; C expressa a consequência clínica.

QUESTÃO 36 — Resposta: D | Fontes: R11

A) tabagismo eleva risco de câncer urotelial.

B) radiação pélvica prévia é fator de risco.

C) aminas aromáticas e corantes industriais aumentam risco.

D) história familiar de hematúria isolada aponta mais para causas benignas/hereditárias que malignidade.

E) idade faz parte da estratificação, embora o ponto de corte isolado de 35 anos esteja desatualizado.

QUESTÃO 37 — Resposta: A | Fontes: R9, R8

A) o adenocarcinoma surge com maior frequência na zona periférica.

B) zona de transição está especialmente relacionada à HPB.

C) zona central é menos frequentemente sítio primário.

D) região periuretral não é a predominante.

E) estroma fibromuscular não é zona glandular predominante de adenocarcinoma.

QUESTÃO 38 — Resposta: C | Fontes: R10

A) cistite eosinofílica tem infiltração eosinofílica, não lesão de Hunner característica.

B) cistite glandular é metaplasia/inflamação da mucosa.

C) lesão de Hunner caracteriza fenótipo inflamatório da cistite intersticial/síndrome da dor vesical.

D) cistite cística exibe ninhos de von Brunn císticos.

E) cistite tuberculosa causa alterações inflamatórias e fibrose específicas.

QUESTÃO 39 — Resposta: E (com ressalva) | Fontes: R9, R8

A) toque retal é importante mas isoladamente pouco sensível para detecção.

B) PSA é teste principal de detecção e estratificação inicial.

C) RM multiparamétrica é útil após suspeita, antes de biópsia em muitos fluxos.

D) US transretal não é exame isolado de primeira linha para rastreio.

E) avaliação inicial clínica pode combinar toque retal e PSA, conforme indicação e decisão compartilhada.

> **Ressalva:** A pergunta mistura rastreamento e confirmação histológica; para rastreio laboratorial o PSA isolado também é defensável.

QUESTÃO 40 — Resposta: C | Fontes: R9, R8

A) cirurgia imediata costuma representar sobretratamento do tumor de muito baixo risco.

B) radioterapia é possibilidade em outros perfis, não escolha obrigatória aqui.

C) vigilância ativa é recomendada quando expectativa de vida e contexto permitem.

D) quimioterapia não é tratamento de câncer prostático localizado de muito baixo risco.

E) hormonioterapia isolada não é indicada nesse cenário.

QUESTÃO 41 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R9, R8

A) disfunção erétil é complicação frequente após prostatectomia radical.

B) incontinência urinária também é relevante, com incidência variável por técnica e seguimento.

C) incontinência fecal não é usual.

D) fístulas urinárias são incomuns.

E) hematúria pode surgir no pós-operatório, mas não é a complicação tardia predominante.

> **Ressalva:** Questão não especifica cirurgia: complicações são diferentes após RTU e prostatectomia radical.

QUESTÃO 42 — Resposta: B | Fontes: R12

A) diplococos Gram-negativos sugerem gonococo.

B) LGV por C. trachomatis explica bubões inguinais/femorais, sinal do sulco e fistulização retal.

C) corpúsculos de Donovan sugerem donovanose, quadro clínico diferente.

D) H. ducreyi está ligado ao cancro mole com úlceras dolorosas.

Ressalva: NAAT na região sintomática é preferível; genotipagem confirma os sorotipos LGV.

QUESTÃO 43 — Resposta: B | Fontes: R4

A) quadro nefrítico isolado não explica adequadamente hipoalbuminemia, lipidúria e hipercolesterolemia.

B) síndrome nefrótica, associada à suspeita de LES, é a melhor integração de dados.

C) há hematúria, porém predomina proteinúria expressiva e lipidúria características nefróticas.

D) glomerulonefrite pós-infecciosa não explica melhor autoimunidade, síndrome nefrótica e marcadores associados.

Ressalva: Unidades de albumina e proteína urinária no enunciado são inconsistentes; histologia exige biópsia quando indicada.

QUESTÃO 44 — Resposta: C (com ressalva) | Fontes: R3, R2

A) ácido úrico não é biomarcador diagnóstico de LRA.

B) ureia varia com volemia e catabolismo e não define isoladamente LRA.

C) NGAL é biomarcador de lesão tubular, potencialmente detectável precocemente.

D) BUN tem limitações semelhantes às da ureia.

Ressalva: Resposta C apenas entre as opções: o padrão recomendado para diagnosticar/acompanhar LRA é creatinina sérica e diurese, que não constam.

QUESTÃO 45 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) G2A1 apresenta risco relativo geralmente baixo.

B) G5A3 combina menor TFG e maior albuminúria, implicando risco máximo.

C) G4A2 é de alto risco, mas inferior a G5A3.

D) G3A3 é de alto risco, inferior a G5A3.

QUESTÃO 46 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) Cockcroft-Gault estima depuração e é útil em ajustes de fármacos específicos, não padrão atual de TFG.

B) CKD-EPI é família de equações; a versão de 2021 sem raça é a alternativa mais específica.

C) MDRD é equação antiga, menos precisa em TFG preservada.

D) CKD-EPI 2021 baseada em creatinina é opção atual, com cistatina C quando disponível.

E) Schwartz é utilizada em crianças.

QUESTÃO 47 — Resposta: E | Fontes: R1, R2

A) Cockcroft-Gault destina-se a adultos.

B) CKD-EPI foi desenvolvida para adultos.

C) MDRD foi validada principalmente em adultos.

D) CKD-EPI 2021 é equação de adultos.

E) equações pediátricas da família Schwartz são apropriadas, em versões atualizadas.

QUESTÃO 48 — Resposta: C | Fontes: R3, R2

A) endotélio não é principal célula lesionada na doença de lesões mínimas.

B) mesângio costuma estar preservado à microscopia óptica.

C) podócitos apresentam apagamento difuso dos pedicelos à microscopia eletrônica.

D) histiócitos não caracterizam a lesão.

QUESTÃO 49 — Resposta: SEM RESPOSTA | Fontes: R3, R2

A) imunocomplexos não se depositam normalmente na luz capilar como local anatomopatológico de GN pós-infecciosa.

B) anticorpos anti-MBG causam doença anti-MBG, não lesões mínimas.

C) ANCA caracteriza vasculite pauci-imune, não nefropatia membranosa.

D) na GN pós-estreptocócica há depósitos granulares sobretudo subepiteliais em gibas, e pode haver lesão podocitária, mas não se define por apagamento difuso dos pedicelos.

Ressalva: A opção D é a aproximação didática, porém nenhuma descreve de modo rigoroso o mecanismo característico.

QUESTÃO 50 — Resposta: C | Fontes: R4

A) nefropatia membranosa costuma produzir síndrome nefrótica, sem sedimentação hemática inflamatória típica.

B) GESF é habitualmente nefrótica e não explica autoanticorpos/complemento baixo de modo tão específico.

C) síndrome nefrítica com nefrite lúpica proliferativa justifica hematúria com cilindros, consumo de complemento e anti-DNA positivo.

D) anti-MBG não é sustentado por esses marcadores de LES.

Ressalva: Emergência hipertensiva e comprometimento respiratório exigem avaliação hospitalar imediata.

QUESTÃO 51 — Resposta: B | Fontes: R3, R2

A) lesão mínima não tem espículas típicas na coloração pela prata.

B) membranosa primária apresenta spikes e anti-PLA2R positivo.

C) GESF mostra cicatrizes segmentares, não spikes predominantes.

D) causas secundárias são possíveis mas anti-PLA2R elevado favorece primária.

QUESTÃO 52 — Resposta: D | Fontes: R3, R2

A) lesões mínimas não são a associação clássica com HIV avançado.

B) GN membranoproliferativa é menos característica nessa apresentação.

C) nefropatia IgA pode ocorrer com HIV, mas não é a forma clássica especificada.

D) nefropatia associada ao HIV tipicamente provoca GESF variante colapsante.

QUESTÃO 53 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) elevação documentada por mais de três meses aponta doença crônica, sem excluir LRA sobreposta.

B) redução da função renal por mais de 3 meses atende definição temporal de DRC.

C) creatinina de 4 mg/dL não representa função normal.

D) doença renal aguda tem duração inferior a três meses, conceito diferente da cronicidade informada.

Ressalva: A classificação de TFG requer idade, sexo e cálculo de TFG.

QUESTÃO 54 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) microalbuminúria histórica é A2, 30-300 mg/g; >300 mg/g é A3.

B) hiperfiltração pode ocorrer inicialmente em doença renal diabética.

C) diabetes pode causar hialinose aferente E eferente.

D) apenas fração dos diabéticos progride até falência renal terminal.

QUESTÃO 55 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) esclerose tuberosa pode cursar com cistos, mas é menos comum.

B) DRPAD é causa frequente de múltiplos cistos bilaterais em adultos.

C) rim em esponja medular caracteriza dilatações de ductos coletores.

D) DRPAR é geralmente doença pediátrica.

Ressalva: Cistos simples múltiplos também são possíveis; faltam idade, história familiar e características de imagem.

QUESTÃO 56 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R1, R2

A) queimadura extensa precoce com perda plasmática pode causar hipovolemia e hiponatremia.

B) hipernatremia hipervolêmica não é o padrão inicial típico.

C) pode existir retenção hídrica no curso clínico, porém não é o padrão inicial obrigatório.

D) hipernatremia hipovolêmica pode aparecer mais tarde por perdas de água e reposição inadequada.

Ressalva: Tempo após queimadura e fluidoterapia determinam o distúrbio; enunciado inespecífico.

QUESTÃO 57 — Resposta: D | Fontes: R3, R2

A) mortalidade tende a aumentar com estágios mais graves de LRA.

B) falência de outros órgãos piora prognóstico.

C) hipoperfusão pré-renal prontamente corrigida costuma ter melhor prognóstico que NTA estabelecida.

D) anúria associa-se a maior gravidade que LRA não oligúrica.

QUESTÃO 58 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) insuficiência renal não obriga hipernatremia.

B) retenção de K por TFG muito baixa e oligúria torna hipercalemia provável.

C) uremia costuma cursar com acidose, não alcalose metabólica obrigatória.

D) perda renal de Mg não é o distúrbio predominante na falência oligúrica.

QUESTÃO 59 — Resposta: C (com ressalva) | Fontes: R1, R2

A) ligação do ferro às meta-hemoglobinas não caracteriza anemia da DRC.

B) na DRC a hepcidina em geral aumenta por menor depuração e inflamação, não diminui.

C) AINEs podem ocasionar sangramento digestivo e agravar anemia.

D) intoxicação por B12 não é mecanismo típico.

Ressalva: A causa central ausente nas opções é deficiência relativa de eritropoetina, associada a deficiência funcional de ferro/inflamação.

QUESTÃO 60 — Resposta: C | Fontes: R1, R2

A) alteração renal aguda causando insuficiência cardíaca é síndrome cardiorrenal tipo 3.

B) doença sistêmica que lesa ambos os órgãos caracteriza tipo 5.

C) lesão cardíaca aguda seguida de LRA é tipo 1.

D) doença renal crônica promovendo disfunção cardíaca é tipo 4.

QUESTÃO 61 — Resposta: C | Fontes: R1, R2

A) não há superioridade universal da diálise peritoneal em sobrevida sobre hemodiálise.

B) diabetes costuma piorar prognóstico em relação a nefropatias não diabéticas.

C) transplante renal em candidato adequado geralmente oferece maior sobrevida e qualidade de vida que diálise.

D) transplante com doador vivo não apresenta menor sobrevida que doador falecido.

QUESTÃO 62 — Resposta: A | Fontes: R1, R2

A) intoxicação por alumínio pode reduzir mineralização, gerando osteomalácia associada à DRC.

B) hiperparatireoidismo terciário associa-se principalmente a doença óssea de alto turnover.

C) excesso de vitamina D pode causar hipercalcemia/doença óssea adinâmica, mas não é causa típica de osteomalácia.

D) deficiência de cálcio isolada não descreve a causa clássica aqui pretendida.

Ressalva: Em pacientes atuais, alumínio é causa menos comum devido às práticas preventivas.

QUESTÃO 63 — Resposta: C | Fontes: R3, R2

A) furosemida não bloqueia diretamente a Na-K-ATPase basolateral.

B) a furosemida não atua primariamente bloqueando o canal luminal de K.

C) bloqueia NKCC2 no ramo ascendente espesso da alça de Henle.

D) efeito paracelular decorre indiretamente da perda do gradiente luminal, não é seu alvo principal.

QUESTÃO 64 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R1, R2

A) espironolactona poupa potássio e pode atenuar perda induzida por tiazídico, mas K de 2,7 exige investigação.

B) associação de alça e tiazídico pode agravar hipocalemia grave.

C) glicerina osmótica não é escolha usual para esse contexto.

D) manitol e acetazolamida não corrigem adequadamente hipocalemia e alcalose na hipertensão.

Ressalva: Suspeitar hiperaldosteronismo primário na hipertensão com hipocalemia; corrigir K e avaliar aldosterona/renina. Tiazídico pode piorar K.

QUESTÃO 65 — Resposta: B | Fontes: R3, R2

A) inibidores seletivos de COX-2 também podem provocar LRA e outros danos renais.

B) queda de PGE2 e prostaciclina reduz vasodilatação renal protetora e a TFG em suscetíveis.

C) não é depósito de metabólitos na membrana glomerular o mecanismo característico de AINE.

D) A e C falsas impedem que todas estejam corretas.

QUESTÃO 66 — Resposta: B | Fontes: R10

A) 5-alfa-redutase converte testosterona em DHT; não hidrolisa DHT, e reduzir DHT diminui proliferação.

B) alfa-1-bloqueadores relaxam musculatura lisa prostática e do colo vesical.

C) seletividade não elimina efeitos como hipotensão ou alterações ejaculatórias.

D) A e C estão erradas.

QUESTÃO 67 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) PKD1 é mais comum do que PKD2.

B) o valor fixo de 100 mOsm/kg não é meta clínica validada para todos.

C) DRPAD tipo 1 costuma ser mais grave que a tipo 2.

D) modelo de dois eventos (second hit) com alterações bialélicas contribui para a formação de cistos.

Ressalva: A doença constitucional é dominante, apesar do mecanismo celular bialélico em muitos cistos.

QUESTÃO 68 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) rabdomiólise causa LRA intrínseca pigmentária.

B) trombose venosa renal é causa vascular intrínseca.

C) HPB ocasiona obstrução pós-renal.

D) insuficiência cardíaca e perdas por diarreia e vômitos produzem hipoperfusão pré-renal.

QUESTÃO 69 — Resposta: A | Fontes: R6

A) E. coli é o agente mais frequente nas ITUs comunitárias.

B) Proteus ocorre sobretudo em contextos específicos e cálculos de estruvita.

C) Klebsiella também é causa, menos predominante.

D) Pseudomonas associa-se a infecções complicadas e cuidado de saúde.

QUESTÃO 70 — Resposta: D | Fontes: R3, R2

A) imunofluorescência não é técnica de rotina para analisar dismorfismo eritrocitário.

B) microscopia óptica comum pode ajudar, mas é menos adequada para caracterização detalhada.

C) microscopia eletrônica não é necessária para exame urinário de rotina.

D) contraste de fase favorece identificação de acantócitos e dismorfismo.

QUESTÃO 71 — Resposta: C | Fontes: R5

A) estruvita está ligada a bactérias produtoras de urease, não é o tipo global mais comum.

B) oxalato de fósforo não é a composição usual descrita para o cálculo mais frequente.

C) oxalato de cálcio é a composição mais frequente.

D) ácido úrico corresponde a parcela menor.

QUESTÃO 72 — Resposta: C (com ressalva) | Fontes: R6

A) resistência de uropatógenos a TMP-SMX costuma ser relevante em muitas regiões.

B) amoxicilina isolada apresenta elevada resistência entre E. coli em diversos locais.

C) nitrofurantoína mantém boa atividade em muitas ITUs baixas não complicadas.

D) resistência a ciprofloxacino varia e pode ser elevada.

Ressalva: A resposta depende do antibiograma local; nitrofurantoína não serve para pielonefrite.

QUESTÃO 73 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) G3b não vai até TFG 49, mas até 44 mL/min/1,73 m².

B) TFG 70-90 é G2/G1 e A1 é <30 mg/g.

C) TFG 15-29 corresponde G4 e >300 é A3.

D) G3b = 30-44; A2 = 30-300 mg/g de creatinina.

QUESTÃO 74 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R1, R2

A) padronização dos critérios de LRA foi finalidade das classificações RIFLE/AKIN/KDIGO.

B) estágios predizem prognóstico, mas não foram criados exclusivamente para mortalidade.

C) estágios ajudam na gravidade, mas não determinam sozinhos indicação de terapia renal substitutiva.

D) B e C não são igualmente objetivos primários.

Ressalva: O enunciado diz KDOQI, mas o sistema mais reconhecido para LRA é KDIGO.

QUESTÃO 75 — Resposta: C | Fontes: R3

A) lesão mínima não produz tipicamente espessamento capilar uniforme.

B) GESF produz cicatrizes segmentares focais.

C) nefropatia membranosa pode ser paraneoplásica, produzindo espessamento da membrana basal e síndrome nefrótica.

D) GN membranoproliferativa cursa com padrão proliferativo e duplicação da MBG.

QUESTÃO 76 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R3

A) síndrome nefrítica após infecção cutânea sugere GN pós-estreptocócica; diurético é indicado se houver sobrecarga.

B) nefrite lúpica não é sustentada por autoimunidade no caso.

C) GN rapidamente progressiva exige evidências adicionais; IECA isolado não trata etiologia.

D) vasculite renal não é primeira hipótese da criança após infecção.

Ressalva: Intervalo de três meses é atípico: usualmente 1-3 semanas após faringite e 3-6 semanas após impetigo.

QUESTÃO 77 — Resposta: A | Fontes: R5

A) hipercalciúria é a anormalidade metabólica frequente em litíase cálcica.

B) hiperoxalúria pode contribuir, mas é menos prevalente.

C) cistinúria é causa genética rara.

D) hipomagnesúria não é a alteração predominante.

QUESTÃO 78 — Resposta: D | Fontes: R5

A) refeição gordurosa pode atrasar absorção de sildenafil e vardenafil, menos para tadalafil.

B) distúrbios visuais por PDE6 são mais atribuídos a sildenafil.

C) tadalafil possui meia-vida mais prolongada.

D) dor lombar e mialgia são relativamente mais associadas a tadalafil, não menos.

QUESTÃO 79 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R5

A) dutasterida inibe duas isoformas de 5-alfa-redutase e reduz DHT mais intensamente.

B) ambas reduzem volume prostático, com percentuais dependentes de dose e tempo.

C) disfunção erétil é evento adverso de ambas, mas frequência não é fixa e idêntica em todos os estudos.

D) não se pode afirmar que a perda de libido seja três vezes maior com finasterida.

Ressalva: C também é excessivamente categórica; D é a afirmação mais claramente infundada.

QUESTÃO 80 — Resposta: D | Fontes: R10

A) tamsulosina e alfuzosina podem ter menos efeitos pressóricos que antagonistas sistêmicos.

B) tamsulosina é de uso muito difundido, ainda que varie por país.

C) combinar alfa-bloqueador com 5-ARI é abordagem reconhecida em prostatas aumentadas.

D) terazosina não é antagonista específico alfa-1C nem é necessariamente a mais potente.

QUESTÃO 81 — Resposta: B | Fontes: R3, R7

A) Doppler pode ser útil se não atrasar exploração indicada.

B) torção deve ser prontamente afastada; cirurgia nas primeiras 6 horas preserva a maioria dos testículos.

C) fixação contralateral é habitualmente indicada.

D) trauma com ruptura/hematoma importante pode demandar cirurgia.

QUESTÃO 82 — Resposta: B | Fontes: R7, R19

A) válvula de uretra posterior pode causar DRC; negar essa possibilidade é falso.

B) RVU não exige cirurgia em todos; prevenção de ITU febril e dano renal é objetivo importante.

C) obstrução de junção pieloureteral pode exigir pieloplastia.

D) injeção endoscópica é opção em casos selecionados de refluxo.

QUESTÃO 83 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R7, R19

A) a maioria das hipospádias é anterior/distal, embora o percentual 'até 50%' seja menor que o descrito em muitas séries.

B) formas proximais são mais complexas que distais.

C) há diferentes técnicas cirúrgicas.

D) formas proximais podem afetar fertilidade por alterações ejaculatórias/anatômicas.

Ressalva: Resposta A pelo sentido principal, com imprecisão quantitativa.

QUESTÃO 84 — Resposta: D | Fontes: R10

A) infecção urinária e prostatite podem elevar PSA.

B) valor fixo de aumento por grama/ano não é parâmetro confiável.

C) relação livre/total maior que 20% tende a ser menos suspeita que uma relação baixa.

D) 5-ARI reduzem o PSA em torno de 50% após 6-12 meses.

QUESTÃO 85 — Resposta: C | Fontes: R10

A) tamanho >40 g e sintomas não implicam cirurgia automaticamente.

B) uretrocistografia não é exame rotineiro para comprovar obstrução prostática.

C) castração pré-púbere impede o estímulo androgênico essencial à HPB.

D) fluxo >150 mL é volume, não parâmetro de descompensação detrusora; fluxo é medido em mL/s.

QUESTÃO 86 — Resposta: D | Fontes: R10

A) neobexiga exige seleção e não é apropriada a todo paciente.

B) alterações ácido-base e eletrolíticas são relevantes nas derivações intestinais.

C) neobexiga intestinal não se contrai como detrusor normal.

D) preservar íleo terminal ajuda a reduzir risco de má absorção de B12 e sais biliares.

QUESTÃO 87 — Resposta: A | Fontes: R15

A) hematoma retroperitoneal expansivo/pulsátil associado a instabilidade é forte indicação exploratória.

B) lesão renal de alto grau pode ser tratada conservadoramente se estável.

C) extravasamento urinário/contraste nem sempre exige cirurgia aberta.

D) estadiamento incompleto não configura isoladamente indicação cirúrgica absoluta.

QUESTÃO 88 — Resposta: C | Fontes: R6

A) Pseudomonas e estafilococos não são agentes predominantes de bacteriúria em gestantes.

B) características de crescimento não tornam diagnóstico de S. saprophyticus automaticamente fácil.

C) S. aureus em urina pode apontar disseminação hematogênica/bacteremia.

D) estreptococo do grupo B não é causa mais comum de ITU nosocomial.

QUESTÃO 89 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R6

A) incontinência na infância pode coexistir com disfunção miccional associada à ITU.

B) alterações hormonais podem influenciar microbiota vaginal e risco, sobretudo após menopausa.

C) atividade sexual é fator importante especialmente para mulheres, menos diretamente início precoce em homens.

D) uso recente de antibióticos pode alterar microbiota e selecionar uropatógenos resistentes.

Ressalva: A redação não delimita populações; fatores sexuais e disfunção miccional também podem predispor.

QUESTÃO 90 — Resposta: C | Fontes: R9, R8

A) zona central é menos frequentemente acometida.

B) tecido fibromuscular anterior não é a localização mais comum.

C) zona periférica concentra a maioria dos adenocarcinomas.

D) zona transicional é sede predominante da HPB.

QUESTÃO 91 — Resposta: A | Fontes: R9, R8

A) T3b indica invasão da vesícula seminal; N0 sem linfonodos; M0 sem metástase distante.

B) T3b não é invasão unilateral confinada e N/M descritos estão incorretos.

C) invasão do elevador do ânus excede T3b e significa T4.

D) envolvimento bilateral não define T3b, e N/M estão incorretos.

Ressalva: Palpabilidade não é requisito formal para categorizar T3b no estadiamento clínico moderno.

QUESTÃO 92 — Resposta: F-V-V-V-F | Fontes: R15

A) FALSA: a maioria das lesões renais traumáticas é contusa, não por arma de fogo.

B) VERDADEIRA: trauma a cavaleiro associa-se a lesão da uretra bulbar/anterior.

C) VERDADEIRA: cistografia retrógrada, convencional ou por TC, é exame de escolha para confirmar ruptura vesical.

D) VERDADEIRA: trauma vesical é predominantemente contuso.

E) FALSA: a maioria dos traumas renais é tratada sem cirurgia em pacientes estáveis.

Ressalva: Os valores V/F inseridos no enunciado foram reavaliados: o item C já aparece assinalado equivocadamente como F.

QUESTÃO 93 — Resposta: B (com ressalva) | Fontes: R12

A) corpúsculos de Donovan identificam donovanose, que geralmente não tem bubão verdadeiro.

B) cancro mole por H. ducreyi produz úlceras dolorosas e bubão unilateral; bacterioscopia é pouco sensível.

C) LGV tipicamente envolve pequena lesão primária transitória e bubões, diferente da úlcera dolorosa ativa descrita.

D) gonococo pode ser diplococo intracelular, mas não causa padrão típico de cancro mole.

Ressalva: A cultura específica ou NAAT de H. ducreyi e exclusão de sífilis/herpes são melhores que Gram isolado.

QUESTÃO 94 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) tiazídicos agem no túbulo contorcido distal, não na alça, e tendem a hiponatremia.

B) diuréticos de alça inibem NKCC2 no ramo ascendente espesso, gerando natriurese potente.

C) osmóticos aumentam, não inibem, fluxo urinário, agindo nos segmentos permeáveis à água.

D) inibidores de anidrase carbônica atuam no túbulo proximal e aumentam bicarbonatúria.

QUESTÃO 95 — Resposta: B (com ressalva) | Fontes: R14

A) aumento de GMPc reduz Ca intracelular e relaxa músculo liso; a afirmação sobre abrir canais Ca está errada.

B) fentolamina bloqueia receptores alfa-adrenérgicos e pode integrar terapias intracavernosas.

C) alprostadil é análogo de PGE1 administrado em formulações intracavernosas ou intrauretrais, não por via sublingual usual.

D) B relaciona corretamente mecanismo e uso, embora 'amplamente utilizado' seja dependente da prática.

Ressalva: Primeira linha normalmente é inibidor de PDE5 oral, não fentolamina.

QUESTÃO 96 — Resposta: SEM RESPOSTA | Fontes: R10

A) 5-alfa-redutase sintetiza DHT a partir de testosterona; não a hidrolisa, e 5-ARI reduzem proliferação.

B) alfa-bloqueadores relaxam musculatura de próstata e colo da bexiga, não o detrusor como ação principal.

C) seletividade não exclui hipotensão nem disfunção ejaculatória.

D) não podem estar todas corretas quando A-C estão erradas.

Ressalva: Questão anulável: nenhuma alternativa tecnicamente correta.

QUESTÃO 97 — Resposta: A | Fontes: R3, R2

A) depósitos subepiteliais ao longo da MBG são característicos da membranosa primária.

B) depósitos subendoteliais sugerem outros processos proliferativos/imunocomplexos.

C) 'submembranosos' não é localização anatômica padrão.

D) depósitos intraendoteliais não definem membranosa.

QUESTÃO 98 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R4

A) classe V de nefrite lúpica tem depósitos subepiteliais característicos.

B) depósitos subendoteliais podem coexistir em lúpus, sobretudo com classes proliferativas.

C) 'submembranosos' é termo anatômico impreciso.

D) 'interendoteliais' não é descrição usual.

Ressalva: Nefropatia membranosa secundária pode ter depósitos mesangiais e subendoteliais além dos subepiteliais.

QUESTÃO 99 — Resposta: A | Fontes: R5

A) LECO pode ser opção para cálculos selecionados até 20 mm, conforme localização/composição.

B) >1000 UH tende a resposta pior.

C) coagulopatia não corrigida contraindica LECO.

D) infecção ativa/obstrução não tratadas podem contraindicar o procedimento.

QUESTÃO 100 — Resposta: B/C | Fontes: R5

A) oxalato de cálcio é composição mais comum, correto.

B) cólica renal resulta sobretudo da obstrução, aumento da pressão e distensão pieloureteral, não simplesmente da cápsula renal.

C) a maioria dos cálculos contém cálcio e é radiopaca, portanto a frase é falsa.

D) cálculos de ácido úrico são radiotransparentes na radiografia simples, correto.

Ressalva: Duas alternativas incorretas (B e C); questão sem chave única.

QUESTÃO 101 — Resposta: C | Fontes: R9, R8

A) fígado não é destino mais característico.

B) pulmão pode ser sítio metastático, mas não é o principal.

C) esqueleto é local mais comum de metástase hematogênica do câncer prostático.

D) rim é muito menos habitual.

QUESTÃO 102 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R14, R16

A) uma semana não comporta espermatogênese.

B) 30 dias é insuficiente.

C) 60 dias aproxima a produção testicular, porém omite trânsito/maturação.

D) cerca de 70-90 dias incluindo maturação epididimária é estimativa didática adequada.

Ressalva: O tempo exato varia entre fontes; 90 dias é arredondamento usado na prova.

QUESTÃO 103 — Resposta: C | Fontes: R14, R16

A) astenozoospermia significa motilidade reduzida.

B) hipospermia é baixo volume ejaculado.

C) teratozoospermia indica morfologia de espermatozoides abaixo do padrão.

D) criptozoospermia é número extremamente baixo detectado no sedimento.

QUESTÃO 104 — Resposta: A | Fontes: R9, R8

A) incidência de câncer vesical é maior nos homens, não nas mulheres.

B) tabagismo é principal fator de risco modificável.

C) aumenta com idade, inclusive 6ª e 7ª décadas.

D) exposição ocupacional a aminas aromáticas está associada ao câncer de bexiga.

QUESTÃO 105 — Resposta: C | Fontes: R9, R8

A) carcinoma urotelial é subtipo predominante, embora porcentagem varie por população.

B) carcinoma escamoso e adenocarcinoma frequentemente são diagnosticados em estágios avançados.

C) Schistosoma haematobium associa-se sobretudo a carcinoma de células escamosas, não adenocarcinoma.

D) adenocarcinoma vesical pode ser secundário a outro sítio e demanda avaliação diferencial.

QUESTÃO 106 — Resposta: SEM RESPOSTA | Fontes: R15

A) hematúria macroscópica é indicação de imagem no trauma renal.

B) micro-hematúria com PAS <90 é critério clássico.

C) desaceleração importante pode justificar imagem sem hematúria.

D) hematúria microscópica volumosa em criança também pode motivar imagem conforme contexto.

Ressalva: Nenhuma é exceção inequívoca; critério isolado >50 hemácias/campo varia entre protocolos pediátricos.

QUESTÃO 107 — Resposta: SEM RESPOSTA | Fontes: R6

A) hiperosmolalidade urinária inibe crescimento de numerosos uropatógenos.

B) ureia urinária contribui para ambiente antibacteriano.

C) ácidos orgânicos urinários podem ter efeito inibitório.

D) pH ácido limita algumas espécies e contribui para defesa.

Ressalva: Todos os itens podem ser fatores protetores; questão carece de exceção clara.

QUESTÃO 108 — Resposta: C | Fontes: R6

A) uretra feminina mais curta favorece ascensão bacteriana.

B) atividade sexual é fator predisponente.

C) modificações hormonais pré-menopausa não configuram risco geral definido; hipoestrogenismo da pós-menopausa é clássico.

D) predisposição genética influencia suscetibilidade.

QUESTÃO 109 — Resposta: C | Fontes: R7, R19

A) Doppler pode ter utilidade, desde que não atrase cirurgia por suspeita forte.

B) salvamento testicular não é quase total até 24 horas; cai muito após 6 horas.

C) orquidopexia contralateral é recomendada quando torção é confirmada.

D) trauma contuso com ruptura testicular pode precisar de cirurgia.

QUESTÃO 110 — Resposta: A | Fontes: R7, R19

A) válvula de uretra posterior pode causar hidronefrose e DRC, correto.

B) RVU tem cinco graus, não quatro, apesar de manejo conservador ser possível.

C) obstrução de junção ureteropiélica frequentemente pode exigir cirurgia, conforme repercussão.

D) injeção endoscópica é possibilidade de tratamento de RVU selecionado.

QUESTÃO 111 — Resposta: D | Fontes: R7, R19

A) maior parte das hipospádias é distal.

B) hipospádias proximais tendem a correção mais complexa.

C) há múltiplas técnicas reconstrutivas.

D) formas posteriores podem comprometer fertilidade por alterações anatômicas.

QUESTÃO 112 — Resposta: A | Fontes: R9, R8

A) infecção urinária/prostatite pode alterar temporariamente PSA.

B) relação numérica fixa com volume prostático por ano não é validada.

C) razão total/livre >20% é inversão equivocada; proporção livre baixa causa maior suspeita.

D) inibidores 5-ARI reduzem PSA cerca de 50%, não somente 10%.

QUESTÃO 113 — Resposta: D | Fontes: R10

A) uretrocistografia não é exame padrão diagnóstico de obstrução prostática.

B) castração antes da puberdade tende a impedir HPB.

C) fluxo >15 mL/s em geral não indica descompensação detrusora.

D) sintomas com próstata >40 g podem ser conduzidos inicialmente sem cirurgia, dependendo de complicações e preferência.

QUESTÃO 114 — Resposta: D | Fontes: R10

A) noctúria é sintoma de armazenamento.

B) urgência é sintoma de armazenamento.

C) polaciúria é sintoma de armazenamento.

D) sensação de esvaziamento incompleto pertence ao grupo pós-miccional.

QUESTÃO 115 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R10

A) finasterida suprime DHT menos intensamente que dutasterida.

B) ambas reduzem volume prostático de forma variável, aproximadamente nessa ordem.

C) efeitos sexuais existem com as duas, mas taxa exata igual não é universal.

D) não há fundamento para prevalência triplicada de perda de libido com finasterida em comparação com dutasterida.

Ressalva: A alternativa C também contém generalização numérica; D é a afirmação mais evidentemente injustificada.

QUESTÃO 116 — Resposta: C | Fontes: R3, R7

A) anti-MBG demonstra depósito linear, diferente do apresentado.

B) membranosa causa depósitos subepiteliais sem hipercelularidade neutrofílica exsudativa predominante.

C) GN pós-infecciosa mostra humps subepiteliais e IgG/C3 granulares.

D) nefropatia diabética apresenta lesões crônicas, não o padrão agudo.

QUESTÃO 117 — Resposta: A | Fontes: R10

A) hiperplasia de glândulas e estroma preservando camadas epiteliais sustenta HPB.

B) glândulas atípicas em camada única sugerem adenocarcinoma.

C) microabscessos neutrofílicos apontam prostatite bacteriana aguda.

D) granulomas caseosos sugerem etiologia tuberculosa.

QUESTÃO 118 — Resposta: C | Fontes: R7, R19

A) coriocarcinoma expressa hCG e linhagem trofoblástica.

B) seminoma não produz glomérulos de Schiller-Duval nem AFP típica.

C) tumor do saco vitelino é marcado por AFP, glóbulos hialinos e estrutura glomeruloide.

D) teratoma reúne tipos teciduais variados.

QUESTÃO 119 — Resposta: C (com ressalva) | Fontes: R1, R2

A) rins policísticos exigiriam dilatação cística característica na imagem.

B) rins normais podem ocorrer na doença renal do diabetes, mas não são regra com TFG tão baixa e albuminúria mínima.

C) nefropatia crônica avançada, sobretudo vascular, frequentemente cursa com rins menores.

D) obstrução bilateral não foi sugerida pela história.

Ressalva: DRC diabética pode preservar tamanho renal; sem ultrassonografia não é possível previsão segura entre B e C.

QUESTÃO 120 — Resposta: C | Fontes: R1, R2

A) DRPAD tipo 1 (PKD1) é a mais frequente.

B) o tipo 1 tende a fenótipo mais grave, não menos.

C) PKD1 localiza-se no cromossomo 16.

D) não há predomínio feminino reconhecido para o tipo 2.

QUESTÃO 121 — Resposta: D | Fontes: R3, R2

A) síndrome nefrótica não traduz o sedimento inflamatório com cilindros hemáticos.

B) nefropatia IgA não explica de modo tão específico pulmão-rim com anti-MBG positivo.

C) GESF costuma causar síndrome nefrótica e não hemorragia pulmonar anti-MBG.

D) síndrome nefrítica/rapidamente progressiva por doença anti-MBG (síndrome de Goodpasture) explica hemorragia pulmonar e LRA.

QUESTÃO 122 — Resposta: B | Fontes: R3, R2

A) trocou edema/albumina e trombose/antitrombina.

B) trombose por perda de ATIII (3), edema por albumina (1), infecção por Ig/complemento (2), distúrbio ósseo por proteína ligadora de vitamina D (4).

C) começa com imunoglobulinas para trombose, incorreto.

D) aloca proteína ligadora de vitamina D à infecção e Ig à alteração óssea.

QUESTÃO 123 — Resposta: B | Fontes: R3

A) hiperfiltração não causa edema e hipertensão nesse quadro.

B) inflamação glomerular reduz TFG e favorece retenção hidrossalina.

C) não é prioritariamente NTA decorrente de infecção sistêmica.

D) hipovolemia não condiz com expansão de volume clássica da GN pós-infecciosa.

QUESTÃO 124 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) corredor sem reposição tende a perder água livre; hiponatremia não é resultado esperado de regra.

B) água com gás também é hipotônica; ganho ponderal sugere excesso relativo de água, não hipernatremia.

C) ambos corredores com ganho de peso após ingerir água dificilmente seriam hipernatrêmicos.

D) excesso de água nos dois primeiros pode causar hiponatremia associada ao exercício; terceiro pode evoluir com hipernatremia por perdas sem reposição.

Ressalva: Valores efetivos dependem da composição das bebidas, suor e excreção renal.

QUESTÃO 125 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) rabdomiólise é causa intrínseca de dano tubular.

B) trombose de veia renal é etiologia vascular intrínseca.

C) HPB causa obstrução pós-renal.

D) insuficiência cardíaca, queimaduras com depleção e vômitos são causas pré-renais.

QUESTÃO 126 — Resposta: B | Fontes: R3, R2

A) vazamento retrógrado agrava disfunção, não aumenta reabsorção tubular normal.

B) perda de polaridade tubular reduz capacidade de reabsorver Na filtrado.

C) aldosterona favorece reabsorção de Na, não secreção.

D) ADH aumenta permeabilidade à água, não explica natriurese da lesão tubular.

QUESTÃO 127 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) AGEs aumentam no diabetes por glicação não enzimática.

B) expansão de matriz mesangial é alteração fisiopatológica importante.

C) há perda/disfunção podocitária, não proliferação importante.

D) via do poliol/sorbitol pode estar ativada, não necessariamente inibida.

QUESTÃO 129 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) fluxo renal pode variar, mas não é o principal mecanismo comum.

B) IECA/BRA diminuem resistência eferente.

C) não aumentam a resistência aferente como efeito renoprotetor principal.

D) dilatação eferente reduz hipertensão intraglomerular e proteinúria.

QUESTÃO 130 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R1, R2

A) AINEs podem reduzir perfusão glomerular e precipitar LRA.

B) IECA/BRA podem piorar função em hipotensão, hipovolemia e estenose renal, mas não são universalmente proibidos em toda LRA.

C) anfotericina B convencional é nefrotóxica.

D) todos merecem avaliação de risco e suspensão temporária quando indicada.

Ressalva: A opção D é a mais abrangente, porém não se deve suspender indiscriminadamente IECA/BRA em todos os cenários.

QUESTÃO 131 — Resposta: C (com ressalva) | Fontes: R13, R1

A) diabetes mellitus equiparou-se à hipertensão como causa atribuída no Censo Brasileiro de Diálise 2024.

B) rim policístico é causa bem menos comum.

C) hipertensão foi historicamente causa mais citada e hoje divide a primeira posição.

D) litíase representa proporção menor das causas dialíticas.

Ressalva: Questão com dado epidemiológico mutável: censo 2024 apontou 29% HAS e 29% diabetes; não há líder isolado atual.

QUESTÃO 132 — Resposta: B | Fontes: R4

A) síndrome nefrítica de GN aguda isolada não explica lipidúria e hipercolesterolemia tão bem.

B) edema, proteinúria marcante, hipoalbuminemia e cilindros gordurosos compõem síndrome nefrótica; sinais sistêmicos favorecem LES.

C) hematúria existe, mas achados predominantes são nefróticos.

D) quadro pós-infeccioso não é o mais provável com FAN elevado e manifestações sistêmicas.

Ressalva: Proteína e albumina têm unidades inconsistentes no documento, e confirmação etiológica exige avaliação especializada.

QUESTÃO 133 — Resposta: B (com ressalva) | Fontes: R6

A) cistite pode gerar disúria e piúria, mas febre e lombalgia favorecem comprometimento alto.

B) pielonefrite é provável com febre, dor lombar, nitrito positivo e cilindros leucocitários.

C) cilindros hemáticos e acentuado dismorfismo sugerem componente glomerular, não explicado plenamente por ITU.

D) não há evidências clínicas suficientes para atribuir LES.

Ressalva: Cilindros hemáticos e hemácias dismórficas no próprio EAS são discordantes da hipótese isolada de pielonefrite; questão imprecisa.

QUESTÃO 134 — Resposta: A | Fontes: R12

A) úlcera muito dolorosa com borda irregular e bubão supurativo sugere cancro mole por H. ducreyi.

B) C. trachomatis LGV tende a úlcera primária discreta, que pode desaparecer antes do bubão.

C) diplococos Gram negativos não justificam o cancro mole típico.

D) corpúsculos de Donovan sugerem donovanose, usualmente indolor e sem linfadenopatia supurativa verdadeira.

Ressalva: Gram isolado tem baixa sensibilidade; cultura específica/NAAT e exclusão de sífilis e herpes são recomendadas.

QUESTÃO 135 — Resposta: D | Fontes: R10

A) a DHT, e não testosterona isoladamente, é principal estímulo androgênico descrito.

B) 5-alfa-redutase converte testosterona em DHT, não o inverso.

C) 5-alfa-redutase é enzima estimuladora, não inibidora dessa conversão.

D) DHT estimula vias parácrinas e fatores de crescimento no estroma prostático.

QUESTÃO 136 — Resposta: B | Fontes: R10

A) tamanho glandular isolado não prediz gravidade sintomática.

B) sintomas dependem também de tônus e anatomia do colo, protrusão do lobo mediano e função vesical.

C) tamanho de 35 g não exige repetição de RM nem biópsia só por sintomas.

D) lobo mediano pode atuar como válvula e causar obstrução relevante mesmo sem próstata volumosa.

QUESTÃO 137 — Resposta: C | Fontes: R10

A) prostatectomia radical é para câncer, não HPB isolada.

B) paciente já utiliza alfa-bloqueador.

C) persistência de sintomas graves e lobo mediano obstrutivo justificam discutir cirurgia endoscópica.

D) anticolinérgicos podem ajudar armazenamento selecionado, mas não corrigem provável obstrução predominante.

Ressalva: Confirmar avaliação clínica, retenção, fluxo, preferência e risco antes da indicação individual.

QUESTÃO 138 — Resposta: A | Fontes: R9, R8

A) extensão à próstata com invasão do estroma enquadra-se T4a; múltiplos linfonodos pélvicos verdadeiros podem corresponder N2 e ausência de metástases distantes M0.

B) T4b/N3/M1 indicariam extensão e metástases não descritas.

C) N3 refere-se a linfonodos ilíacos comuns, não simplesmente múltiplos pélvicos.

D) T4b implica invasão da parede pélvica/abdominal não descrita.

Ressalva: A confirmação T4a requer invasão do estroma prostático, não apenas extensão mucosa/ductal.

QUESTÃO 139 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R9, R8

A) radioterapia externa isolada não é manejo padrão de tumor vesical de alto grau sem invasão muscular.

B) nova RTU pode ser necessária, mas não contempla imunoterapia intravesical de alto risco.

C) BCG é componente da terapêutica, mas alguns casos precisam nova RTU antes.

D) repetir RTU quando indicado e iniciar BCG após adequada ressecção é a opção mais segura entre propostas.

Ressalva: A indicação de re-RTU depende de Ta/T1, presença de músculo detrusor e completude da primeira ressecção; enunciado não informa esses pontos.

QUESTÃO 140 — Resposta: C (com ressalva) | Fontes: R9, R8

A) vigilância ativa não é usual para Gleason 4+3 (ISUP 3).

B) cirurgia pode ser apropriada, mas cintilografia óssea não é obrigatória em todo paciente.

C) prostatectomia radical é alternativa com estadiamento individualizado; cintilografia tem indicação relativa/condicionada ao risco.

D) RM é importante em diversos fluxos, mas cintilografia obrigatória e cirurgia para todos não decorrem desses dados.

Ressalva: Propostas atuais podem incluir radioterapia e estadiamento molecular PSMA-PET quando apropriado; prognóstico e expectativa de vida são indispensáveis.

QUESTÃO 141 — Resposta: B (com ressalva) | Fontes: R9, R8

A) radioterapia é opção curativa, mas não necessariamente superior ao seguimento neste baixo grau.

B) vigilância ativa é apropriada em tumor de baixo risco com expectativa de vida suficiente e adesão ao acompanhamento.

C) bloqueio hormonal isolado não é tratamento padrão para câncer localizado de baixo risco.

D) prostatectomia radical pode gerar sobretratamento em idoso com tumor pouco agressivo.

Ressalva: Se expectativa de vida for inferior a 10 anos, observação/watchful waiting pode ser mais apropriada do que vigilância ativa estrita.

QUESTÃO 142 — Resposta: D | Fontes: R3, R2

A) só a primeira afirmativa é verdadeira, portanto esta sequência F-V-F-F está invertida.

B) terceira afirmativa é falsa: furosemida não bloqueia receptor de angiotensina.

C) quarta afirmativa é falsa: não é antagonista da aldosterona.

D) primeira é verdadeira pelo bloqueio de NKCC2 e as outras três são falsas.

QUESTÃO 143 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R1, R2

A) espironolactona antagoniza aldosterona e poupa K, compensando parcialmente tiazídico.

B) duplo bloqueio de Na com alça e tiazídico tende a agravar perdas de K.

C) glicerina osmótica não é esquema de escolha.

D) manitol e acetazolamida não são primeira linha e podem agravar desequilíbrios.

Ressalva: K 2,7 mEq/L requer correção, ECG e investigação de hiperaldosteronismo primário; associar tiazídico nem sempre é adequado.

QUESTÃO 144 — Resposta: B | Fontes: R3, R2

A) inibidores seletivos de COX-2 também podem lesar o rim.

B) queda de PGE2 e PGI2 por AINEs reduz vasodilatação das arteríolas renais e TFG.

C) depósito glomerular de metabólitos não explica o mecanismo predominante.

D) A e C são falsas.

QUESTÃO 145 — Resposta: A/B | Fontes: R6

A) e B têm o mesmo diagnóstico escrito, pielonefrite; a opção A contém somente um '1' sem conteúdo médico.

B) pielonefrite é sustentada por febre, lombalgia e nitrito positivo, com leucocitúria/cilindros leucocitários.

C) presença de cilindros hemáticos levanta hipótese glomerular, mas não explica isoladamente febre/lombalgia/nitrito.

D) não há evidência sistêmica específica de LES no enunciado.

Ressalva: Questão sem resposta única: A e B duplicadas. Além disso, cilindros hemáticos/dismorfismo intenso exigem avaliação glomerular.

QUESTÃO 146 — Resposta: A (com ressalva) | Fontes: R12

A) úlcera genital dolorosa e bubão supurativo sugerem H. ducreyi; Gram é pouco sensível.

B) pesquisa de clamídia dirige-se ao LGV, geralmente de úlcera primária discreta.

C) gonococo não explica o padrão clínico; a própria linha do original contém trecho mesclado com outra alternativa.

D) 'aumento de consultas preventivas' não é exame nem responde ao caso clínico.

Ressalva: A alternativa C está materialmente corrompida no original; não foram reconstruídas palavras por suposição.

QUESTÃO 147 — Resposta: C | Fontes: R3

A) quadro nefrítico com cilindros hemáticos não é explicável por cistite comum.

B) tumor renal não explica adequadamente instalação pós-impetigo com síndrome nefrítica típica.

C) impetigo há duas semanas seguido de edema, hipertensão, hematúria e cilindros hemáticos sugere GN pós-infecciosa.

D) nefrite lúpica exigiria indícios adicionais de doença sistêmica.

QUESTÃO 148 — Resposta: B | Fontes: R17

A) radioterapia isolada não é escolha para massa renal localizada pequena.

B) nefrectomia parcial é tratamento padrão preferencial para massa renal T1a (4 cm ou menos) tecnicamente ressecável.

C) 4,0 cm não é T2a (maior que 7 e até 10 cm).

D) realce sólido não exclui câncer e impede assumir benignidade.

Ressalva: Abordagem laparoscópica/robótica depende da anatomia, equipe e paciente.

QUESTÃO 149 — Resposta: A | Fontes: R17

A) evitar tabaco, controlar obesidade e atividade física saudável são medidas preventivas.

B) câncer renal responde por porcentagem menor do total de neoplasias que 5-8% em muitas séries.

C) carcinoma de células claras é o subtipo mais frequente.

D) incidência registrada não diminuiu simplesmente pelo aumento de prevenção.

QUESTÃO 150 — Resposta: C | Fontes: R5

A) cálculo coraliforme ocupa pelve e cálices, não necessariamente todo o ureter.

B) cálculos de oxalato de cálcio não são dissolvidos por terapia química habitual.

C) cálculo de ácido úrico é radiotransparente no RX simples.

D) estruvita é fosfato de amônio e magnésio, relacionada a bactérias produtoras de urease.

QUESTÃO 151 — Resposta: D | Fontes: R7, R19

A) varicocele assintomática não exige tratamento universal.

B) tratamento clínico não resolve anatomicamente refluxo venoso na maioria, embora observação seja usual.

C) varicocele é mais frequentemente esquerda, não sempre bilateral.

D) diagnóstico é clínico, auxiliado por ultrassom Doppler em cenários selecionados.

QUESTÃO 152 — Resposta: B | Fontes: R5

A) ureteroscopia oferece taxas livres de cálculo geralmente maiores que LECO para ureter distal.

B) distância pele-cálculo/IMC influencia eficácia da onda de choque.

C) LECO não é universalmente superior a nefrolitotripsia por tamanho sem considerar composição e localização.

D) cálculos calicinais inferiores costumam ter menor eliminação após LECO.

QUESTÃO 153 — Resposta: C | Fontes: R7, R19

A) obstrução unilateral de junção pieloureteral não explica tão bem bexiga distendida e oligoidrâmnio.

B) refluxo pode causar hidronefrose, mas tríade com bexiga muito distendida em feto masculino sugere obstrução infravesical.

C) válvula de uretra posterior ocasiona obstrução infravesical, hidronefrose bilateral e oligodrâmnio.

D) hidrocele comunicante é anomalia escrotal, não obstrução urinária alta.

QUESTÃO 154 — Resposta: C (com ressalva) | Fontes: R5

A) laparoscopia não é primeira opção de rotina para cálculo distal.

B) taxas variam por cálculo e técnica; número fixo de 80% não define superioridade.

C) ureteroscopia frequentemente fornece maior taxa livre de cálculos em uma sessão que LECO para ureter distal.

D) cirurgia aberta é rara em litíase ureteral atual.

QUESTÃO 155 — Resposta: C | Fontes: R9, R8

A) zona central não é a localização predominante de câncer prostático.

B) zona anterior pode albergar tumores, mas não a maioria.

C) zona periférica é a mais acometida por adenocarcinoma.

D) zona de transição é principalmente sede de HPB.

QUESTÃO 156 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R1, R2

A) débito <0,5 mL/kg/h por 12 h atende critério de LRA.

B) aumento de creatinina >=0,3 mg/dL em 48h atende KDIGO.

C) >=1,5 vez do basal documentado dentro de 7 dias atende critério.

D) apenas 'presumida' sem dizer que alteração ocorreu nos sete dias prévios é insuficiente como formulação independente.

> **Ressalva:** A KDIGO aceita creatinina 1,5 vez conhecida OU presumida ter ocorrido nos sete dias prévios. Como esse prazo está omitido em D, a questão é ambígua.

QUESTÃO 157 — Resposta: D | Fontes: R1, R2

A) uso de diuréticos pode induzir hipovolemia predisponente.

B) idade avançada eleva risco.

C) diabetes é fator de suscetibilidade.

D) alergia à penicilina isolada não define risco basal elevado de LRA.

QUESTÃO 158 — Resposta: C | Fontes: R1, R2

A) tipo 1 associa-se ao gene PKD1, não PKD2.

B) PKD1 está no cromossomo 16 e PKD2 no 4.

C) DRPAD tipo 1 costuma ser clinicamente mais grave e mais precoce.

D) transmissão é autossômica dominante sem predominância por sexo.

QUESTÃO 159 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) hiponatremia dilucional deriva de excesso de água relativa, não perda urinária isolada de sódio.

B) DRC pode cursar com retenção de água e hiponatremia.

C) deslocamento para terceiro espaço não é o mecanismo usual de diluição plasmática.

D) tiazídicos podem agravar hiponatremia.

QUESTÃO 160 — Resposta: C | Fontes: R3, R2

A) síndrome nefrótica não explica síndrome pulmão-rim com anti-MBG.

B) nefropatia por IgA não explica anti-MBG positivo.

C) doença anti-MBG/Goodpasture produz hemorragia alveolar e glomerulonefrite rapidamente progressiva.

D) GESF geralmente cursa com síndrome nefrótica e não hemorragia alveolar anti-MBG.

QUESTÃO 161 — Resposta: A | Fontes: R3, R2

A) associa TVP a perda de antitrombina III (3), edema a albumina (1), infecção a Ig/complemento (2), alterações ósseas a proteína ligadora de vitamina D (4).

B) inicia TVP por perda de Ig, incorreto.

C) troca complicações infecciosas e metabólicas.

D) edema não decorre da perda urinária de ATIII na sequência fornecida.

QUESTÃO 162 — Resposta: B | Fontes: R3, R2

A) aumento da filtração não corresponde ao quadro nefrítico oligúrico.

B) queda da TFG e retenção hidrossalina provocam edema e HAS.

C) NTA secundária a infecção não explica a síndrome nefrítica pós-impetigo.

D) hipovolemia não é causa típica do edema e hipertensão.

QUESTÃO 163 — Resposta: D | Fontes: R3, R2

A) lesão mínima não apresenta esclerose segmentar.

B) membranoproliferativa apresenta padrão proliferativo e duplicação da MBG.

C) membranosa causa espessamento capilar e spikes.

D) GESF é definida por lesão em parte dos glomérulos e parte do tufo, e pode ocorrer na obesidade.

QUESTÃO 164 — Resposta: B | Fontes: R1, R2

A) correção rápida de hiponatremia crônica causa desmielinização osmótica, não edema cerebral.

B) sede preservada e água disponível protegem contra hipernatremia importante.

C) mielinólise pontina não é efeito da correção rápida de hipernatremia.

D) diabetes insípido tende a hipernatremia por perda de água livre.

QUESTÃO 165 — Resposta: C | Fontes: R1, R2

A) glomerulonefrite crônica tende a rins pequenos em estágios avançados.

B) nefrosclerose hipertensiva costuma produzir diminuição renal.

C) doença renal diabética frequentemente mantém rins normais ou aumentados, mesmo com DRC.

D) pielonefrite crônica tende a cicatrizes e redução de volume.

QUESTÃO 166 — Resposta: D | Fontes: R3

A) GN pós-estreptocócica é mais comum na idade escolar que antes de dois anos.

B) nem todos os casos exigem hospitalização; depende gravidade.

C) hematúria de origem glomerular costuma ter hemácias dismórficas.

D) controle de edema e HAS inclui restrição de sal/água conforme estado e diuréticos de alça.

QUESTÃO 167 — Resposta: D | Fontes: R7, R19

A) ultrassom identifica anomalias grosseiras, mas é menos sensível a cicatrizes corticais.

B) urografia excretora é exame antigo com limitações.

C) DTPA é útil para perfusão, função e drenagem, não melhor para cicatrizes corticais.

D) DMSA é padrão de referência para detectar cicatrizes corticais por pielonefrite/refluxo.

E) TC fornece detalhes, mas irradia e não é exame preferencial de rotina em crianças.

QUESTÃO 168 — Resposta: E | Fontes: R9, R8

A) ultrassom transretal não é primeiro teste para suspeita oncológica por imagens ósseas.

B) biópsia prostática exige avaliação clínica/PSA e indicação específica.

C) TC abdominal não é primeiro exame mais dirigido diante de padrão osteoblástico.

D) biópsia óssea não é a primeira investigação simples.

E) PSA é exame inicial apropriado para pesquisar origem prostática de metástases osteoblásticas em homem idoso.

QUESTÃO 169 — Resposta: D (com ressalva) | Fontes: R6

A) coleta por cateter pode ser válida, mas envolve manipulação invasiva e contaminação possível.

B) coleta por porta de cateter de demora pode ser apropriada, desde que técnica estéril e contexto correto.

C) jato médio é método recomendado na maioria dos pacientes cooperantes, com mínima invasão.

D) punção suprapúbica oferece a amostra mais livre de contaminação uretral.

E) jato inicial tem maior risco de contaminação.

Ressalva: A 'mais confiável' microbiologicamente é D, mas na prática usual prefere-se jato médio bem coletado.

QUESTÃO 170 — Resposta: SEM RESPOSTA | Fontes: R14, R16

A) a afirmação 1 (10-20% dos homens inférteis) subestima varicocele em muitas populações, e 2-3 não são corretas.

B) 2 (70-80% gravidez após cirurgia) é taxa exagerada e 4 recomenda cirurgia universal indevida.

C) ambas 2 e 4 são falsas.

D) 2, 3 e 4 são falsas: dor não indica operação em todos os casos.

E) 2 é falsa e a indicação cirúrgica por dor exige seleção, não universalidade.

Ressalva: Nenhuma combinação é correta; varicocele aparece em aproximadamente 35-40% dos homens com infertilidade primária e cirurgia é seletiva.

QUESTÃO 171 — Resposta: C | Fontes: R3, R2

A) nefrite túbulo-intersticial é causa menos frequente de LRA intrínseca.

B) necrose cortical é incomum e grave.

C) necrose tubular aguda é causa clássica predominante de LRA intrínseca hospitalar.

D) GN rapidamente progressiva é menos prevalente.

Ressalva: A principal causa de LRA de todas as categorias inclui hipoperfusão pré-renal; como não há essa opção, C é a melhor.

REFERÊNCIAS UTILIZADAS

Fontes institucionais consultadas para conferir recomendações, critérios diagnósticos e epidemiologia. As referências são agrupadas por tema e associadas às questões pelo código R correspondente.

R1. KDIGO 2024 | Avaliação e tratamento da doença renal crônica. Abrir fonte oficial / artigo
https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/

R2. KDIGO 2012 | Definições, diagnóstico e estadiamento da lesão renal aguda. Abrir fonte oficial / artigo
https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/

R3. KDIGO 2021 | Diretriz de doenças glomerulares. Abrir fonte oficial / artigo
https://kdigo.org/guidelines/gd/

R4. KDIGO 2024 | Diretriz de nefrite lúpica. Abrir fonte oficial / artigo
https://kdigo.org/guidelines/lupus-nephritis/

R5. EAU 2026 | Urolitíase. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis/chapter/guidelines

R6. EAU 2026 | Infecções urológicas. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/urological-infections

R7. EAU 2026 | Urologia pediátrica, escroto agudo e anomalias. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/paediatric-urology

R8. EAU 2026 | Câncer de bexiga não músculo-invasivo. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/non-muscleinvasive-bladder-cancer/chapter/diagnosis

R9. EAU 2026 | Câncer de próstata e estadiamento. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/chapter/classification-and-staging-systems

R10. AUA 2026 | Sintomas urinários atribuíveis à hiperplasia prostática benigna. Abrir fonte oficial / artigo
https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000005098

R11. AUA/SUFU 2025 | Investigação da micro-hematúria. Abrir fonte oficial / artigo
https://www.auajournals.org/doi/epdf/10.1097/JU.0000000000004490

R12. CDC 2021 | Diretrizes de infecções sexualmente transmissíveis. Abrir fonte oficial / artigo
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7004a1.htm

R13. Inquérito Brasileiro de Diálise 2024 | Etiologias atribuídas à falência renal. Abrir fonte oficial / artigo
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12922704/

R14. EAU 2026 | Saúde sexual e reprodutiva. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/sexual-and-reproductive-health

R15. EAU 2026 | Traumatismos urológicos. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/urological-trauma/chapter/urogenital-trauma-guidelines

R16. OMS 2021 | Manual laboratorial de análise seminal, 6ª edição. Abrir fonte oficial / artigo
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030787/

R17. EAU 2026 | Carcinoma renal e nefrectomia parcial. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/renal-cell-carcinoma/chapter/disease-management

R18. EAU 2026 | Litíase e orientação terapêutica cirúrgica. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis/chapter/guidelines

R19. EAU 2026 | Refluxo vesicoureteral em crianças. Abrir fonte oficial / artigo
https://uroweb.org/guidelines/paediatric-urology/chapter/vesicoureteric-reflux

Observação metodológica: este documento constitui uma avaliação independente das respostas preexistentes. Não substitui diretrizes clínicas, conduta individualizada ou gabarito oficial. Enunciados materialmente incompletos, desatualizados ou contraditórios foram preservados e identificados nos comentários, sem completar por suposição.